



Nuansa
Fajar
Cemerlang

PEMANFAATAN LEAFLET SEBAGAI MEDIA EDUKASI KESEHATAN

PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA PADA WANITA USIA SUBUR

Legina Anggraeni
Frida Putri Maharani



Pemanfaatan Leaflet Sebagai Media Edukasi Kesehatan: Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Wanita Usia Subur

**Lgina Anggraeni, SST., MKM.
Frida Putri Maharani, Amd.Keb.**



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Pemanfaatan Leaflet Sebagai Media Edukasi Kesehatan: Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Wanita Usia Subur

Penulis: Legina Anggraeni, SST., MKM.
Frida Putri Maharani, Amd.Keb.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7139-06-1

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Pemanfaatan leaflet sebagai media edukasi kesehatan : pencegahan dan deteksi dini kanker payudara pada wanita usia subur / penulis, Legina Anggraeni, SST., MKM., Frida Putri Maharani, Amd.Keb.
Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
81 halaman ; 30 cm
ISBN 978-634-7139-06-1
Payudara - Kanker -- Iklan - Pendidikan kesehatan -- Promosi kesehatan
616.994 490 52 [23]
<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1187006>

Prakata

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur selalu tercurah kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tidak dapat dihitung setiap harinya kepada kita makhluk ciptaan-Nya. Shawalat berbalut salam juga selalu tercurah kehadirat Nabi Muhammad SAW. Berkat limpahan kasih dari Allah SWT pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan sebuah buku monograf yang merupakan buah dari hasil penelitian yang berjudul ***"Pemanfaatan Leaflet Sebagai Media Edukasi Kesehatan: Pencegahan Dan Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Wanita Usia Subur"***. Buku monograf ini kami buat karena rasa kepedulian kami kepada masyarakat terutama kepada kaum wanita dalam melakukan deteksi dini kanker payudara sebagai langkah preventif di bidang kesehatan reproduksi.

Buku ini membahas bukan hanya dari konsep umum deteksi dini kanker payudara namun membahas media yang dapat digunakan dalam melakukan edukasi kesehatan yaitu media leaflet. Leaflet merupakan media yang sudah lama digunakan dalam edukasi kesehatan dan merupakan media yang dinilai ringkas karena tidak terbatas pada listrik dan jaringan internet, sehingga sangat mudah digunakan pada wilayah dengan keterbatasan sumber daya tersebut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat mulai dari awal proses penelitian hingga buku ini selesai diterbitkan. Kami juga menyadari jika buku ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami meminta dengan kerendahan hati untuk diberikan saran dan kritik membangun agar dapat disempurkan pada masa mendatang. Akhir kata kami tim penulis mengucapkan selamat membaca buku

monograf ini, harapannya buku ini dapat membawa manfaat kepada para pembaca dalam meningkatkan pengetahuan terkait deteksi dini kanker payudara.

"Menulis akan mengajarmu bahwa apa yang kamu ucapkan dapat dengan mudah dilupakan. Namun, apa yang kamu tuliskan dapat dengan mudah diukirkan pada dinding sejarah peradaban"

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Desember 2024

Tim Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
---------------------	------------

Daftar Isi.....	v
------------------------	----------

Bab 1 Pendahuluan	1
--------------------------------	----------

Bab 2 Konsep Dasar Kanker Payudara dan Wanita Usia	
---	--

Subur.....	8
-------------------	----------

A. Definisi Wanita Usia Subur (WUS)	8
---	---

B. Tanda Wanita dalam Usia Subur.....	9
---------------------------------------	---

C. Definisi Kanker Payudara	9
-----------------------------------	---

D. Tanda dan Gejala Kanker Payudara	15
---	----

E. Stadium Kanker Payudara.....	16
---------------------------------	----

F. Pengobatan Kanker Payudara.....	20
------------------------------------	----

G. Kanker Payudara Selama Kehamilan	21
---	----

H. Deteksi Dini Kanker Payudara	24
---------------------------------------	----

I. Faktor Risiko Kanker Payudara	28
--	----

Bab 3 Konsep Dasar Edukasi Kesehatan.....	31
--	-----------

A. Definisi Media Edukasi Kesehatan.....	31
--	----

B. Tujuan dan Manfaat Media Edukasi Kesehatan .	32
---	----

C. Hubungan Edukasi Kesehatan dengan Promosi Kesehatan	33
--	----

D. Prinsip Edukasi Kesehatan	36
------------------------------------	----

E. Tahap Pelaksanaan Edukasi Kesehatan	36
--	----

F. Strategi Edukasi Kesehatan	37
-------------------------------------	----

G. Metode Edukasi Kesehatan.....	38
----------------------------------	----

H. Model Konseptual dalam Edukasi Kesehatan	41
--	----

I. Proses Edukasi Kesehatan	45
-----------------------------------	----

J. Sasaran Edukasi Kesehatan	47
------------------------------------	----

Bab 4 Konsep Pemanfaatan Media Leaflet dalam Edukasi Kesehatan Kanker Payudara.....	48
A. Definisi Media Edukasi	48
B. Manfaat Media Edukasi Kesehatan	49
C. Prinsip Penggunaan Media dalam Edukasi Kesehatan	50
D. Jenis Media Edukasi Kesehatan.....	50
E. Kriteria Memilih Media Edukasi Kesehatan.....	52
F. Pemanfaatan Media Leaflet dalam Edukasi Kesehatan	53
Bab 5 Penutup	55
 Daftar Pustaka	 57
Glosarium	68
Profil Penulis.....	73

Bab 1

Pendahuluan

Kanker merupakan suatu penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian tertinggi dan kasusnya terus meningkat di dunia. Data yang tercatat secara global menyebutkan bahwa sebesar 18,7% kematian di dunia disebabkan karena kanker. Kondisi di Indonesia tidak berbeda jauh, kanker menempati posisi ketiga penyebab kematian tertinggi setelah penyakit jantung dan stroke (Kemenkes, 2024). *Global Burden of Cancer* (Globocan) pada tahun 2020 menyebutkan bahwa diseluruh dunia estimasi jumlah kasus baru kanker sebesar 11,7% dan sekitar 6,95% menyebabkan kematian (Jack Cordes, 2021).

Salah satu jenis kanker yang sering menyerang wanita adalah kanker payudara. Kanker payudara didefinisikan sebagai sebuah pertumbuhan sel-sel ganas di dalam jaringan payudara. Kanker jenis ini biasanya mulai tumbuh dan berkembang di daerah saluran kelenjar air susu (Kemenkes, 2022). Sebanyak 2,3 juta kasus baru kanker payudara terdiagnosis setiap tahunnya dan kanker payudara mewakili 24,2 % dari semua diagnosis kanker yang terjadi pada wanita serta menyumbang angka kematian sebesar 15% di seluruh dunia (Francies et al., 2020).

Kejadian kanker payudara akan lebih tinggi terjadi di Negara-Negara maju seperti di kawasan Amerika dan Eropa dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Asia. Namun, insiden kanker payudara akan lebih cepat meningkat di negara-negara berkembang salah satunya di Indonesia (ESMO, 2018). Kondisi di Indonesia terkait dengan kanker cukup memprihatinkan. Angka kejadian baru penderita kanker tertinggi pada perempuan adalah kanker payudara dengan besaran 41,8% dengan angka kematiannya mencapai 14,4% (Kemenkes, 2022).

Angka kematian dari suatu penyakit dapat menggambarkan kejadian penyakit, kesadaran akan deteksi dini dan pengobatan penyakit tersebut di suatu negara. Pada negara berkembang, angka kematian yang disebabkan oleh kanker payudara lebih tinggi dibanding negara maju, hal ini disebabkan karena saat penderita datang kefasilitas kesehatan sudah dengan kanker stadium dalam tahap lanjut dan disebabkan juga karena kurangnya akan kesadaran deteksi dini dan pengobatan terbatas. Oleh karena itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, deteksi dan pengobatan kanker sejak dini atau pada stadium awal bisa menekan angka kematian yang disebabkan oleh kanker payudara (Shidqi et.al, 2022). Penyebab angka kematian diakibatkan kanker payudara sangat tinggi dikarenakan oleh keterlambatan penanganan pasien di rumah sakit, karena penanganan pasien kanker stadium lanjut tidak terlalu efektif terhadap perkembangan penyembuhan pada pasien kanker payudara.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko kanker payudara, antara lain bertambahnya usia, obesitas, penggunaan alkohol yang berbahaya, riwayat keluarga kanker payudara, riwayat paparan radiasi, riwayat reproduksi (seperti usia saat menstruasi dimulai dan usia saat kehamilan pertama),

penggunaan tembakau, dan terapi hormon *pascamenopause*. Sekitar setengah dari kanker payudara berkembang pada wanita yang tidak memiliki faktor risiko kanker payudara yang dapat diidentifikasi salah satunya adalah usia yang berada di atas 40 tahun. Riwayat keluarga kanker payudara meningkatkan risiko kanker payudara, tetapi sebagian besar wanita yang didiagnosis dengan kanker payudara tidak memiliki riwayat keluarga yang mengidap penyakit tersebut. Tidak adanya riwayat keluarga yang diketahui tidak selalu berarti bahwa seorang wanita memiliki risiko yang lebih rendah. (WHO, 2024a).

Saat ini, sekitar 80% pasien kanker payudara adalah individu berusia >50 tahun, sementara pada saat yang sama lebih dari 40% adalah mereka yang berusia lebih dari 65 tahun. Risiko terkena kanker payudara meningkat sebesar 1,5% pada usia 40 tahun, 3% pada usia 50 tahun, dan lebih dari 4% pada usia 70 tahun (Mcguire et al., 2015). Riwayat keluarga yang menderita kanker payudara merupakan faktor utama yang berhubungan secara signifikan dengan peningkatan risiko kanker payudara. Sekitar 13–19% pasien yang didiagnosis menderita kanker payudara melaporkan adanya kerabat tingkat pertama yang menderita kondisi yang sama. Selain itu, risiko kanker payudara meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah kerabat tingkat pertama yang menderita; risikonya mungkin lebih tinggi ketika kerabat yang menderita berusia di bawah 50 tahun (Shiyanbola, 2018) (Brewer et al., 2017).

Beberapa mutasi genetik dilaporkan sangat terkait dengan peningkatan risiko kanker payudara. Dua gen utama yang ditandai dengan penetrasi tinggi adalah BRCA1 (terletak pada kromosom 17) dan BRCA2 (terletak pada kromosom 13). Keduanya terutama terkait dengan peningkatan risiko

karsinogenesis payudara (Shiovitz & Korde, 2015). Mutasi dalam gen yang disebutkan di atas sebagian besar diwariskan secara dominan autosomal, namun, mutasi sporadis juga sering dilaporkan. Gen kanker payudara dengan penetrasi tinggi lainnya termasuk TP53, CDH1, PTEN, dan STK11 (Jackson, 2020) (Corso, Intra, & Trentin, 2016). Wanita yang ditemukan memiliki mutasi pada gen utama ini dapat mempertimbangkan strategi pengurangan risiko seperti operasi pengangkatan kedua payudara atau strategi kemoprevensi (WHO, 2024a). Strategi kemoprevensi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencegah, menunda, atau menekan insiden tumor menggunakan agen bioaktif sintesis atau alami. Secara mekanistik, agen kemopreventif juga membantu mengurangi perkembangan kanker, baik dengan menghambat kerusakan DNA atau dengan menghalangi pembelahan sel premaligna dengan kerusakan DNA (Shankar et al., 2022).

Faktor risiko lainnya yang mencetuskan timbulnya kanker payudara adalah riwayat reproduksi wanita. Beberapa penelitian mengonfirmasi hubungan erat antara paparan hormon estrogen dan progesteron terhadap risiko kanker payudara. Terjadinya peristiwa tertentu seperti kehamilan, menyusui, menstruasi pertama, dan menopause dan ketidakseimbangan hormon yang menyertainya, sangat penting dalam hal potensi untuk meningkatkan karsinogenik pada payudara wanita. Selain itu, kehamilan itu sendiri memberikan efek perlindungan terhadap potensi kanker (Husby, 2018). Durasi periode menyusui yang lebih lama juga mengurangi risiko kanker payudara (Lukasiewicz et al., 2021). Usia *menarche* dini merupakan faktor risiko lain kanker payudara; hal ini mungkin juga terkait dengan tingkat tumor dan keterlibatan kelenjar getah bening. Selain itu, usia menstruasi pertama yang lebih awal dapat mengakibatkan prognosis yang lebih buruk secara

keseluruhan. Sebaliknya, menopause dini, baik alami maupun karena hal bedah (operasi pengangkatan rahim) dapat menurunkan risiko kanker payudara.

Aktivitas fisik yang teratur dianggap sebagai faktor pelindung dari kejadian kanker payudara. Penelitian menyebutkan bahwa, aktivitas fisik dikaitkan dengan penurunan risiko kanker pada wanita dengan riwayat keluarga kanker (Chen et al., 2019). Aktivitas fisik bermanfaat tidak hanya pada wanita dengan riwayat keluarga kanker payudara tetapi juga pada mereka yang tidak memiliki riwayat tersebut. Aktivitas fisik dapat mencegah kanker dengan mengurangi paparan hormon seks endogen, mengubah respons sistem imun atau kadar faktor pertumbuhan mirip insulin-1 (Lukasiewicz et al., 2021).

Walaupun kanker payudara memiliki insiden tertinggi dan angka kematian tinggi pada penderitanya namun, kanker payudara dapat dideteksi secara dini dengan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri). SADARI merupakan langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan oleh wanita sebagai salah satu cara untuk deteksi dini kanker payudara untuk memeriksa dan mencari benjolan yang dicurigai atau kelainan lainnya pada payudaranya sendiri (Rochmawa et al., 2021). Deteksi dini pada kanker payudara tidak hanya menurunkan angka mortalitas dan morbiditas, namun juga akan menurunkan biaya pengobatan yang harus dikeluarkan kemudian hari (Blumen et al., 2016).

Selain upaya SADARI yang dilakukan oleh Wanita Usia Subur (WUS) perlu diberikan juga edukasi terkait penyakit kanker payudara sebagai langkah preventif. Salah satu komponen yang penting untuk diberikan edukasi adalah pengetahuan mengenai pentingnya deteksi dini kanker payudara (Sobri, 2022). Penderita kanker payudara terkadang tidak mempunyai pengetahuan yang baik dalam melakukan

pengobatan atau bahkan penderita mengalami tahap *ignorancy* atau penolakan terhadap diagnosa kanker payudara karena penderita merasa gejala yang dirasakan tidak mengarah ke kanker payudara sehingga penderita seperti mengulur waktu untuk mendapatkan pengobatan kanker payudara.

Sarana yang dapat digunakan dalam penyampaian pengetahuan terkait kanker payudara maupun upaya pencegahannya adalah melalui edukasi kesehatan. Tujuan dari dilakukannya edukasi kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan diri sendiri, mengubah sikap dan menerapkan praktik hidup sehat dalam keseharian (Mustaqimah, 2023). Media dalam edukasi kesehatan yang paling sering digunakan yaitu *leaflet* dengan keunggulan seperti mudah untuk dibawa, ringkas dan dapat disimpan dengan cukup mudah (Pratiwi et al., 2022). Leaflet juga digolongkan dalam media ajar yang ringkas mensosialisasikan perilaku hidup sehat di masyarakat. Bentuknya berupa lembaran sehingga dinilai lebih praktis untuk dilipat dan tidak perlu menggunakan listrik ataupun jaringan internet terutama pada wilayah yang masih terbatas akses listrik (Dameria et al., 2023). Leaflet sebagai media edukasi juga dinilai dapat memberikan visualisasi pengetahuan yang jelas sehingga masyarakat awam sekalipun akan mudah menerima dan memahami isi dari materi yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Iryanti, 2021) menjelaskan bahwa rata – rata tingkat pengetahuan tentang kanker payudara sebelum dilakukan edukasi menggunakan media leaflet adalah 56,46. Kemudian setelah dilakukan edukasi menggunakan media *leafleat* didapatkan peningkatan nilai pengetahuan sebesar 27,08 poin atau sebesar 83,54. Pengetahuan WUS yang kurang memadai akan menyebabkan sikap abai terhadap kesehatan diri bahkan sikap yang kurang

peduli terhadap inisiatif melakukan deteksi dini akan membuat penderita cenderung merugi terutama dalam proses identifikasi awal kanker payudara (Raihanny, 2024). Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut diperlukan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan WUS terutama terkait dengan pencegahan dan deteksi dini kanker payudara mengingat peluang untuk sembuh dari kanker payudara cukup besar terutama jika dapat dideteksi sedini mungkin.

Bab 2

Konsep Dasar Kanker Payudara dan Wanita Usia Subur

A. Definisi Wanita Usia Subur (WUS)

Wanita Usia Subur atau sering dikenal dengan sebutan WUS merupakan wanita yang berada pada usia reproduksi yaitu sekitar usia 15-49 tahun (WHO, 2024b) sedangkan, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) WUS diartikan sebagai wanita yang berumur antara 15 – 49 tahun baik dengan status kawin maupun bukan status kawin, atau dapat dikatakan wanita dengan usia 15-49 tahun dan sudah mengalami menstruasi yang memiliki peluang untuk hamil jika melakukan hubungan seksual.

Hubungan antara WUS dengan deteksi dini kanker payudara adalah ketepatan waktu bagi wanita untuk melakukan pemeriksaan payudara karena kanker payudara stadium lanjut ditemukan pada wanita usia lanjut artinya stadium awal kanker payudara terjadi pada usia subur. Jadi, deteksi dini kanker payudara akan lebih efektif jika dilakukan wanita saat usia subur.

B. Tanda Wanita dalam Usia Subur

Menurut (Nofia & Indrayani, 2022) tanda wanita yang khas saat berada di usia subur dapat diketahui melalui dua cara yaitu:

1. Siklus menstruasi

Siklus menstruasi diartikan sebagai jarak antara tanggal mulainya menstruasi yang lalu dan mulainya menstruasi berikutnya. Pada umumnya WUS yang sehat akan mengalami siklus menstruasi antara 28-35 hari setiap siklusnya (Fauziah et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut, siklus menstruasi dapat menjadi tanda terpenting apakah wanita masuk kedalam kategori WUS.

2. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik lengkap dapat dijadikan pertimbangan apakah wanita tersebut termasuk dalam klasifikasi WUS. Beberapa organ tubuh, seperti payudara, kelenjar tiroid dan organ reproduksi dapat menjadi salah satu pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, pemeriksaan payudara dapat memperlihatkan apakah hormon prolaktin didalam tubuh tinggi atau tidak. Karena, kandungan hormon prolaktin yang tinggi akan mengganggu proses pengeluaran sel telur. Selain itu, pemeriksaan sistem reproduksi lengkap juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah wanita tersebut memiliki sistem reproduksi yang sehat atau tidak.

C. Definisi Kanker Payudara

Kanker merupakan penyakit yang termasuk kedalam kategorisasi penyakit tidak menular yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak normal secara cepat dan tidak terkendali. Pertumbuhan sel ini dapat merusak jaringan sekitarnya serta dapat menyebar ke tempat yang jauh dari

asalnya yang disebut sebagai metastasis. Sel kanker ini bersifat ganas dan dapat berasal atau tumbuh dari setiap jenis sel di tubuh manusia (Liambo et al., 2022). Sedangkan, kanker payudara didefinisikan sebagai pertumbuhan sel-sel payudara yang dapat menimbulkan keganasan pada tubuh. Keganasan yang terjadi berasal dari komponen kelenjar payudara, jaringan lemak, pembuluh darah dan saraf jaringan payudara tergantung dimana sel kanker tumbuh di payudara (Sihite et al., 2019).

Kanker payudara adalah tumor ganas yang paling sering ditemukan pada wilayah *High Income Countries* (HICs) dan *Low and Middle-Income Countries* (LMICs) (Setyowibowo et al., 2018). Namun kematian tertinggi justru terjadi di negara-negara berkembang, dikarenakan tingkat kesadaran untuk melakukan deteksi dini masih sangat rendah (Francies et al., 2020). Maka dapat disimpulkan pada negara-negara berkembang wanita yang terdiagnosa kanker payudara akan mengakses pengobatan pada stadium lanjut sehingga angka kematiannya akan tinggi.

C. Klasifikasi Kanker Payudara

Menurut *National Breast Cancer Foundation* (2024) ada beberapa jenis kanker payudara yang sering ditemukan pada penderita kanker payudara, diantaranya :

1. *Ductal Carcinoma in Situ* (DCIS)

DCIS merupakan kanker yang tumbuh di lapisan duktus atau saluran ASI, sel – sel abnormal belum menyebar dari dalam ke luar duktus atau sekitarnya. DCIS adalah kanker yang bisa dideteksi secara dini dan kanker bisa diobati dengan peluang kesembuhan yang banyak, namun jika kanker ini tidak dideteksi secara dini sehingga

tidak segera diobati maka sel – sel kanker akan menyebar ke sekitar jaringan payudara.

2. *Invasive Ductal Carcinoma* (IDC)

IDC merupakan jenis kanker yang bersifat invasif. Sel – sel yang tidak normal yang awalnya terbentuk di duktus sudah menyebar ke saluran luar duktus atau kebagian lain jaringan payudara bahkan sel kanker ini bisa menyebar kebagian tubuh lain sehingga kanker ini disebut karsinoma duktal infiltratif atau kanker yang bisa menyebarkan sel kanker dari tempat asal ke sekitar jaringan yang merupakan non kanker. IDC merupakan jenis paling umum dari kanker payudara karena penderita kanker IDC merupakan 70-80% bagian dari seluruh penderita yang mendapat diagnosa kanker payudara.

3. *Lobular Carcinoma in Situ* (LCIS)

LCIS merupakan jenis kanker payudara dimana sel – sel yang tidak normal ditemukan di lobulus atau kelenjar susu. Pada jenis ini, sel – sel atipikal belum menyebar dari lobulus keluar jaringan payudara. Kanker jenis ini bukan merupakan kanker invasif atau menyebar dan sangat bisa diobati, namun jika penderita yang menderita LCIS pada satu payudara maka resiko terkena kanker pada kedua payudara dengan jenis yang sama akan meningkat.

4. *Invasive Lobular Cancer* (ILC)

ILC merupakan lanjutan dari LCIS atau dapat dikatakan ILC adalah LCIS yang sudah menyebar ke jaringan normal di sekitar lobulus atau kelenjar payudara. Penyebaran ILC dimulai dari lobulus lalu sel – sel abnormal menyebar melalui darah dibantu oleh pembuluh darah dan sistem getah bening ke bagian tubuh lain. ILC merupakan jenis kanker payudara yang paling umum kedua setelah IDC. Lebih dari 10% penderita kanker payudara menderita

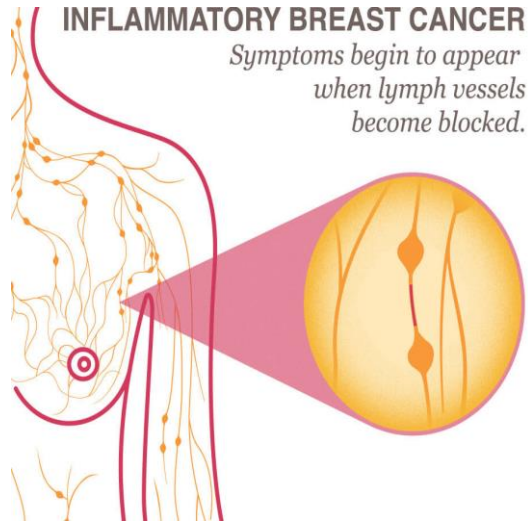
kanker jenis ILC. Jenis kanker ini jarang terdeteksi melalui mammogram, sehingga dibutuhkan pemeriksaan MRI saat mammogram ditemukan sel kanker payudara untuk memastikan apakah jenis kanker penderita termasuk ke dalam ILC atau jenis lain agar segera mendapatkan penanganan yang tepat sesuai jenis kanker yang diderita.

5. *Medullary Carcinoma* (MC)

MC merupakan kanker dengan karakteristik berbatas tegas, yang tersusun atas sel-sel berdiferensiasi buruk yang tumbuh dalam pola sinsitial tanpa struktur kelenjar, stroma jarang, dan infiltrat limfoplasmasitik menonjol. MC adalah entitas yang berbeda dari karsinoma mammae. Secara kasar, karsinoma ini menunjukkan batas tegas dan dapat disalahartikan sebagai fibroadenoma. Permukaan yang dipotong berwarna cokelat keabu-abuan. Secara mikroskopis, karsinoma meduler adalah massa yang berbatas tegas dengan batas yang mengembang dan "mendorong" ke jaringan payudara yang berdekatan. Sel-sel tumor menunjukkan tingkat nukleus yang tinggi dan berkelompok dalam pola sinsitial dengan jumlah infiltrat limfoplasmasitik yang jelas (Peng, Yan, 2013).

6. *Inflammatory Breast Cancer* (IBC)

IBC merupakan jenis kanker payudara yang langka dan agresif, yang mencakup 1 hingga 5% dari semua kasus kanker payudara. IBC terjadi ketika sel kanker menyusup ke kulit dan pembuluh limfatik payudara. IBC lebih sulit didiagnosis daripada jenis kanker payudara lainnya dan cenderung terjadi pada wanita yang lebih muda. Kanker ini juga menyebar lebih cepat daripada jenis kanker payudara lainnya.



Gambar 2.1 *Inflammatory Breast Cancer*

Sumber: (*National Breast Cancer Foundation, 2024*)

7. *Metastatic Breast Cancer* (MBC)

MBC adalah kanker payudara stadium 4 yang telah menyebar dari lokasi awalnya di payudara ke area tubuh lainnya. Istilah metastasis digunakan untuk mendefinisikan proses penyebaran sel kanker ke area tubuh lainnya. Kanker payudara metastatik juga disebut kanker payudara stadium lanjut. Kanker payudara metastatis terjadi ketika kanker telah mulai menyebar ke bagian tubuh lainnya.

METASTATIC BREAST CANCER

The cancer has started to spread to other parts of the body.



Gambar 2.2 Metastatic Breast Cancer

Sumber: (National Breast Cancer Foundation, 2024)

Ketika kanker payudara kambuh, atau kembali, ke bagian tubuh lainnya beberapa bulan atau tahun setelah diagnosis dan pengobatan kanker payudara awal (juga disebut sebagai kekambuhan jarak jauh), hal itu disebut kanker payudara metastatik. Ketika diagnosis pertama kanker payudara bersifat metastatik, hal itu disebut kanker payudara metastatik de novo. Ini biasanya berarti bahwa kanker telah menyebar keluar dari payudara dan ke area tubuh lainnya pada saat diagnosis awal kanker payudara dibuat.

Saat ini belum ada obat yang tersedia untuk kanker payudara metastatik, tetapi semakin banyak wanita yang hidup lebih lama dengan penyakit ini dengan mengelolanya sebagai penyakit kronis dengan fokus pada kualitas hidup sebagai tujuan utama. Fokus pengobatan adalah untuk mengendalikan penyakit melalui pengobatan dan pemantauan berkelanjutan.

D. Tanda dan Gejala Kanker Payudara

Menurut (Kemenkes, 2019) ciri yang paling khas dari penyakit kanker payudara adalah munculnya benjolan di kedua atau salah satu payudara. Benjolan tersebut biasanya memiliki tekstur yang padat, keras, memiliki batas yang tidak jelas, dapat menempel dengan permukaan yang tidak rata. Biasanya benjolan ini tidak menimbulkan rasa sakit ataupun nyeri sehingga banyak wanita yang mengabaikan benjolan ini.

National Breast Cancer Foundation (2024) mengemukakan bahwa, selain munculnya benjolan di payudara ada beberapa gejala awal yang perlu diketahui oleh wanita yaitu sebagai berikut:

1. Pori – pori membesar pada kulit payudara sehingga menyebabkan perubahan tekstur kulit payudara yang menyerupai kulit jeruk.
2. Penebalan di area dalam payudara atau area dekat payudara seperti ketiak dan disertai nyeri putting.
3. Bentuk atau ukuran payudara berubah karena alasan yang tidak dapat dijelaskan oleh penderita.
4. Bagian payudara seperti tertarik ke dalam membentuk lengkungan atau seperti lesung pipit.
5. Pembengkakan pada satu sisi payudara
6. Penyusutan pada satu sisi payudara
7. Asimetri (bentuk payudara yang kurang atau tidak sama) pada payudara namun secara tiba-tiba.
8. Asimetri payudara pada wanita merupakan hal yang umum terjadi, namun jika asimetri terjadi secara tiba-tiba maka harus segera diperiksa
9. Putting seperti tersedot kedalam

10. Puting, areola dan kulit payudara berubah menjadi merah, bersisik atau bengkak atau menyerupai kulit jeruk
11. Keluarnya cairan padahal sedang tidak menyusui, biasanya cairan yang keluar pada kasus kanker payudara adalah cairan berwarna bening dan darah.

E. Stadium Kanker Payudara

Penomoran stadium kanker dilakukan untuk mengetahui seberapa parah tingkatan penyakit kanker tersebut. *Cancer Research* UK (2020) membagi stadium kanker payudara menjadi 4 yaitu:

1. Stadium 1

Kanker payudara stadium 1 berarti kankernya kecil dan hanya ada di jaringan payudara atau mungkin ditemukan di kelenjar getah bening yang dekat dengan payudara. Ini adalah kanker payudara stadium awal. Stadium kanker menggambarkan seberapa besar kankernya dan seberapa jauh penyebarannya. Ini membantu dokter untuk memutuskan perawatan terbaik untuk.

Penentuan stadium kanker payudara sangat rumit. Banyak faktor berbeda yang dipertimbangkan sebelum dokter dapat memastikan stadium akhir. Kanker stadium 1 dapat dibagi menjadi 1A dan 1B. Berikut ini adalah penjelasan sederhana dari kanker payudara stadium 1A dan 1B.

a. Stadium 1A

Stadium 1A diartikan sebagai munculnya kanker payudara yang berukuran 2 cm atau lebih kecil dan belum menyebar ke area luar payudara

b. Stadium 1B

Stadium 1B berarti bahwa beberapa sel kanker payudara ditemukan di kelenjar getah bening yang dekat dengan payudara dan pada beberapa kasus sel kanker tersebut tidak ditemukan di payudara atau sel kanker tersebut berukuran 2 cm atau lebih kecil.

2. Stadium 2

Kanker payudara stadium 2 berarti kanker berada di payudara atau di kelenjar getah bening di dekatnya atau keduanya. Ini adalah kanker payudara stadium awal. Stadium kanker memberi tahu seberapa besar kanker tersebut dan seberapa jauh penyebarannya. Ini membantu dokter dalam memutuskan perawatan terbaik untuk pasiennya. Penentuan stadium kanker payudara sangat rumit. Banyak faktor berbeda yang dipertimbangkan sebelum dokter dapat memastikan stadium akhir.

Stadium 2 dapat dibagi menjadi 2A dan 2B. Berikut adalah penjelasan sederhana dari kanker payudara stadium 2A dan 2B.

a. Stadium 2A

Pada stadium 2A seorang pasien akan memiliki salah satu dari gambaran berikut ini.

Pertama: tidak ditemukan kanker di payudara atau kanker payudara berukuran 2 sentimeter (cm) atau kurang, dan sel kanker ditemukan di 1 hingga 3 kelenjar getah bening di ketiak atau di kelenjar getah bening dekat tulang dada.

Kedua: kanker berukuran lebih besar dari 2 cm tetapi tidak lebih besar dari 5 cm dan tidak ada kanker di kelenjar getah bening.

b. Stadium 2B

Pada stadium 2B seorang pasien akan memiliki salah satu dari gambaran berikut ini.

Pertama: Kanker berukuran lebih besar dari 2 cm tetapi tidak lebih besar dari 5 cm dan terdapat area kecil sel kanker di kelenjar getah bening.

Kedua: Kanker berukuran lebih besar dari 2 cm tetapi tidak lebih besar dari 5 cm dan kanker telah menyebar ke 1 hingga 3 kelenjar getah bening di ketiak atau ke kelenjar getah bening di dekat tulang dada.

Ketiga: Kanker berukuran lebih besar dari 5 cm dan belum menyebar ke kelenjar getah bening.

3. Stadium 3

Stadium 3 berarti kanker telah menyebar dari payudara ke kelenjar getah bening di dekat payudara, ke kulit payudara, atau ke dinding dada. Disebut juga kanker payudara stadium lanjut. Stadium 3 dapat dibagi menjadi 3A, 3B, dan 3C.

Berikut ini adalah penjelasan sederhana dari kanker payudara stadium 3A, 3B, dan 3C.

a. Stadium 3A

Pada stadium 3A seorang pasien akan memiliki salah satu dari gambaran berikut ini.

Pertama: tidak terlihat kanker di payudara atau kanker berukuran berapa pun di dalam payudara.

Kedua: terdapat kanker di 4 hingga 9 kelenjar getah bening di bawah lengan atau di kelenjar getah bening dekat tulang dada.

Ketiga: kanker berukuran lebih besar dari 5 cm dan telah menyebar ke 1 hingga 3 kelenjar getah bening di bawah lengan atau ke kelenjar getah bening dekat tulang dada.

b. Stadium 3B

Stadium 3B berarti kanker telah menyebar ke kulit payudara atau dinding dada. Dinding dada berarti struktur yang mengelilingi dan melindungi paru-paru, seperti tulang rusuk, otot, kulit, atau jaringan ikat. Kanker telah menyebabkan kulit rusak (ulkus) atau menyebabkan pembengkakan. Kanker mungkin telah menyebar hingga ke-9 kelenjar getah bening di ketiak atau ke kelenjar getah bening di dekat tulang dada. Kanker yang telah menyebar ke kulit payudara mungkin merupakan kanker payudara inflamasi.

c. Stadium 3C

Stadium 3C berarti kanker dapat berukuran berapa pun, atau mungkin tidak ada kanker yang terlihat di payudara. Kanker mungkin telah tumbuh ke dinding dada atau kulit payudara. Kanker telah menyebar ke salah satu area seperti sepuluh atau lebih kelenjar getah bening di ketiak. Kelenjar getah bening di atas atau di bawah tulang selangka. Kelenjar getah bening di ketiak dan dekat tulang dada.

4. Stadium 4

Kanker payudara stadium 4 telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kanker ini juga disebut kanker stadium lanjut atau kanker payudara sekunder. Tujuan dari pengobatan pada stadium ini adalah untuk mengendalikan kanker dan gejala-gejala yang muncul. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang kanker payudara stadium 4 yaitu:

- a. Kanker dapat berukuran berapa pun
- b. Kelenjar getah bening mungkin terdapat ataupun tidak sel kanker

- c. Kanker telah menyebar (bermetastasis) ke bagian tubuh lain seperti tulang, paru-paru, hati, atau otak.

F. Pengobatan Kanker Payudara

Menurut *Icon Cancer Center* (2024) umumnya, terdapat lima pilihan jenis pengobatan, dan sebagian besar rencana penanganann kanker payudara yaitu:

1. Pembedahan

Operasi atau pembedahan biasanya dilakukan sebagai pengobatan yang paling sering dijalani oleh pasien kanker payudara. Pembedahan dapat dilakukan untuk mengoperasi tumor atau jaringan kanker payudara, serta untuk mengidentifikasi penyebaran kanker ke area lain yang memungkinkan seperti ke area kelenjar getah bening. Pembedahan terkadang bertujuan untuk mengembalikan bentuk payudara jika dimungkinkan. Menurut *National Breast Cancer Foundation* (2024) jenis-jenis pembedahan kanker payudara diklasifikasikan menjadi lumpektomi, mastektomi parsial atau mastektomi radikal dan rekonstruksi.

2. Kemoterapi

Kemoterapi merupakan metode pengobatan dengan menggunakan kombinasi obat-obatan untuk menghancurkan atau memperlambat sel kanker. Kemoterapi merupakan terapi sistemik atau obat bekerja di dalam aliran darah ke seluruh tubuh dengan tujuan menyebarkan obat untuk memperlambat atau menghancurkan sel kanker yang telah tersebar ke seluruh tubuh. Obat yang digunakan dalam kemoterapi adalah obat sitotoksik atau beracun bagi sel dan diberikan secara oral atau intravena. Obat-obatan ini dapat diberikan pada setiap tahap pengobatan kanker payudara, mulai dari

mengecilkan tumor besar pra-operasi hingga menghancurkan sel kanker yang mungkin tersisa pasca-operasi.

3. Radiasi

Radiasi atau nama lainnya adalah radioterapi merupakan sebuah metode pengobatan dan penanganan kanker melalui radiasi dengan memberantas atau mengurangi pertumbuhan sel kanker dan meringankan gejala dengan aman. Metode ini umumnya diterapkan pasca-operasi untuk mengurangi risiko kambuhnya kanker.

4. Terapi Hormon

Terapi hormon atau terapi endokrin merupakan pengobatan yang berfokus untuk menghambat atau menurunkan kadar hormon alami tubuh yang bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan atau kembalinya kanker yang sensitif terhadap hormon. Obat ini dapat diberikan dalam bentuk tablet oral, suntikan di bawah kulit atau suntikan di bawah otot.

5. Terapi Bertarget

Terapi bertarget merupakan sebuah prosedur pengobatan kanker payudara yang bertujuan untuk menghancurkan sel-sel kanker saja dan tetap mempertahankan sel-sel yang masih normal atau sehat. Metode pengobatan terapi bertarget digunakan dalam kombinasi dengan kemoterapi standar, terapi bertarget memiliki efek samping yang cenderung lebih ringan dari obat kemoterapi standar.

G. Kanker Payudara Selama Kehamilan

Kanker payudara dapat didiagnosis selama kehamilan, meskipun jarang terjadi dan kanker payudara tidak disebabkan oleh kehamilan. Wanita yang didiagnosis kanker

payudara selama kehamilan memiliki tekanan tambahan yang sangat besar karena kekhawatiran akan keselamatan bayi yang belum lahir. Ini bisa menjadi situasi yang traumatis dan sangat sulit, tetapi masih ada harapan bagi ibu dan anak, berkat banyaknya pilihan pengobatan yang tersedia. Pasien hamil dengan kanker payudara mungkin menunjukkan gejala serupa, seperti benjolan yang teraba atau keluarnya cairan dari puting payudara. Namun, diagnosis sering kali terlambat karena perubahan fisiologis payudara selama kehamilan, termasuk pembengkakan, hipertrofi, keluarnya cairan dari puting payudara, dan peningkatan kepadatan jaringan payudara (Boere & Lok, 2022).

Pengobatan kanker payudara selama kehamilan memerlukan pertimbangan cermat terhadap kesehatan ibu dan janin. Faktor risiko kanker payudara selama kehamilan sama dengan faktor risiko pada wanita yang tidak hamil, dengan usia ibu saat hamil menjadi semakin signifikan. Meskipun kehamilan umumnya melindungi terhadap kanker payudara, usia ibu yang masuk kedalam kategori berisiko (> 35 tahun) dapat meningkatkan paparan hormon, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara (Mumtaz, Otey, & Afridi, 2024).

Rencana dalam pengobatan selama kehamilan memerlukan kolaborasi dari tim multidisiplin yang harus menilai dan mempertimbangkan masalah medis (obstetri), onkologi, radioterapi, pediatrik, molekuler (dan klinis), genetik, etika, dan psikologis. Pasien dan pasangannya perlu diberi konseling dengan hati-hati tentang pilihan pengobatan, risiko ibu dan janin, serta keputusan tentang kelanjutan atau penghentian kehamilan. Namun, yang penting diketahui bahwa terminasi kehamilan belum terbukti meningkatkan hasil yang lebih baik dalam proses

pengobatan (Cardonick, Gilmandyar, & Somer, 2012). Seperti halnya wanita yang tidak hamil, pembedahan biasanya merupakan langkah pertama untuk mengobati kanker payudara stadium awal. Pembedahan selama kehamilan dapat dilakukan dengan aman dengan risiko yang kecil bagi ibu dan bayi yang belum lahir, sehingga dokter kemungkinan besar akan melanjutkan dengan mengangkat benjolan melalui lumpektomi atau mastektomi, dan mungkin beberapa kelenjar getah bening dari bawah lengan (*National Breast Cancer Foundation*, 2024).

Pengobatan optimal pada ibu dengan kanker payudara harus dipertimbangkan dengan baik agar risiko bahaya yang diterima oleh janin akan minimal (Sarah & Frédéric, 2009). Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan memiliki dampak besar pada hasil akhir janin atau bayi baru lahir. Kecemasan dan depresi yang dirasakan oleh ibu selama masa kehamilan berdampak negatif pada aspek klinis pengalaman persalinan dan, secara tidak langsung mempengaruhi nilai *Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration* (APGAR) (Smorti, Ponti, & Tani, 2019). Anak-anak yang terpapar pengobatan kanker dari ibu mereka dalam kandungan perlu diawasi terhadap efek samping awal dan jangka panjang serta dukungan psikososial dari keluarga, sebagai standar perawatan (Voigt et al., 2015).

Hasil jangka panjang dari anak-anak yang terpapar kemoterapi pada trimester kedua atau ketiga kehamilan tampak meyakinkan berdasarkan laporan tentang hasil kehamilan yang terpapar pada usia 3 dan 6 tahun (Vandenbroucke et al., 2020). Stadium kanker dan usia kehamilan menentukan jenis pengobatan kanker selama kehamilan, dan beberapa pengobatan ini berdampak buruk pada pertumbuhan janin. Misalnya, kemoterapi dapat

menyebabkan toksisitas sumsum tulang dan anemia janin (Wolters et al., 2021). Selain itu, dalam penelitian lain (Zhang et al., 2019), hasilnya menunjukkan bahwa kemoterapi memiliki dampak buruk pada janin seperti malformasi, toksisitas organ, dan keterlambatan perkembangan.

H. Deteksi Dini Kanker Payudara

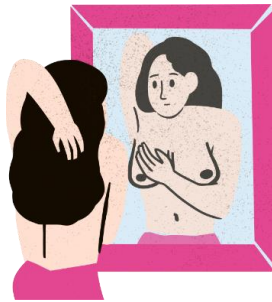
Deteksi dini kanker payudara adalah pemeriksaan atau usaha untuk menemukan abnormalitas yang mengarah pada kanker payudara pada seseorang atau kelompok orang yang tidak mempunyai keluhan. Tujuan dari skrining adalah untuk menurunkan angka morbiditas akibat kanker payudara dan angka kematian. Pencegahan sekunder merupakan hal utama dalam penanganan kanker secara keseluruhan. Deteksi dini ditujukan untuk mendapatkan kanker payudara dini sehingga hasil pengobatan menjadi efektif, dengan demikian akan menurunkan kemungkinan kekambuhan, menurunkan mortalitas dan memperbaiki kualitas hidup.

Beberapa upaya deteksi dini yang dapat dilakukan oleh wanita usia subur menurut Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Payudara yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun (2018) antara lain:

1. Periksa Payudara Sendiri (SADARI)

SADARI dilakukan oleh masing-masing wanita, mulai dari usia 20 tahun. SADARI dilakukan setiap bulan, 7-10 hari setelah hari pertama haid terakhir. SADARI merupakan upaya untuk mengetahui awal mula terjadinya beberapa penyakit yang bisa menyerang payudara seperti pembengkakan kelenjar getah bening, tumor hingga kanker payudara. Berikut langkah-langkah SADARI menurut (Kemenkes RI, 2016):

- a. Berdiri tegak. Cermati bila ada perubahan pada bentuk dan permukaan kulit payudara, pembengkakan dan/atau perubahan pada puting.
- b. Angkat kedua lengan ke atas, tekuk siku dan posisikan tangan di belakang kepala. dorong siku ke depan dan cermati payudara; dan dorong siku ke belakang dan cermati bentuk maupun ukuran payudara.



Gambar 2.3 Langkah SADARI poin a dan b

Sumber: (dokumentasi pribadi)

- c. Posisikan kedua tangan pada pinggang, condongkan bahu ke depan sehingga payudara menggantung, dan dorong kedua siku ke depan, lalu kencangkan (kontraksikan) otot dada.
- d. Angkat lengan kiri ke atas, dan tekuk siku sehingga tangan kiri memegang bagian atas punggung. Dengan menggunakan ujung jari tangan kanan, raba dan tekan area payudara, serta cermati seluruh bagian payudara kiri hingga ke area ketiak. Lakukan gerakan atas-bawah, gerakan lingkaran dan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting, dan sebaliknya. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan Anda.



Gambar 2.4 Cara Melakukan Perabaan SADARI

Sumber: (dokumentasi pribadi)

- e. Cubit kedua puting. Cermati bila ada cairan yang keluar dari puting.
- f. Pada posisi tiduran, letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan ke atas. Cermati payudara kanan dan lakukan tiga pola gerakan seperti sebelumnya. Dengan menggunakan ujung jari-jari, tekan-tekan seluruh bagian payudara hingga ke sekitar ketiak.

2. Periksa Payudara Klinis (SADANIS)

SADANIS (Periksa Payudara Klinis) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau tenaga kesehatan profesional untuk mengenali jenis-jenis kelainan pada payudara sebagai tanda peringatan terjadinya kanker payudara. Jika, saat dilakukan SADARI ditemukan sesuatu yang tidak biasa pada payudara, maka harus segera dilakukan SADANIS oleh ahli untuk memastikan kelainan yang dirasakan apakah termasuk ke dalam gejala kanker payudara atau yang lainnya. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan klinis payudara, maka dapat ditentukan apakah memang betul ada kelainan, dan apakah kelainan tersebut termasuk kelainan jinak, ganas, atau perlu

pemeriksaan lebih lanjut sehingga membutuhkan rujukan ke Tingkat Pelayanan Kesehatan Sekunder atau Tersier. SADANIS dapat dilakukan sekurangnya 3 tahun sekali atau apabila ditemukan adanya abnormalitas pada proses SADARI.

3. Mammografi

Mammografi merupakan pemeriksaan lanjutan dari SADANIS yang menggunakan radiasi X-Ray dalam memeriksa jaringan payudara yang abnormal atau mencurigakan. Mammografi sangat berguna sebagai prosedur untuk melakukan penapisan dan memantau pasien yang memiliki resiko tinggi terhadap kanker payudara pada semua wanita diatas 40 tahun, serta sebagai sarana untuk mendeteksi tumor primer yang secara klinis masih tersembunyi pada pasien yang datang dengan kanker payudara metastatik (Sari, Surahmi, & Supriyanti, 2023).

Untuk jenis payudara tertentu, mammogram bisa jadi sulit ditafsirkan. Hal ini karena ada variasi yang luas dalam kepadatan jaringan payudara di antara wanita. Payudara yang lebih padat lebih sulit untuk dicitrakan, dan lebih sulit untuk dinilai untuk diagnosis tumor. Karena alasan ini dan alasan lainnya, sensitivitas mamografi dalam mendeteksi kanker dapat bervariasi dalam rentang yang luas. Mammografi merupakan *gold standard* dari skrining kanker payudara. Mammografi dapat mendiagnosis kanker payudara lebih awal sebelum adanya tanda klinis yang muncul pada pasien. Pemberian terapi yang sesuai dapat dilakukan pada stadium awal dan dapat menurunkan angka kematian. Kelebihan dari metode deteksi dini menggunakan mammografi selain menurunkan angka kematian dan meningkatkan

pengobatan di stadium awal juga dapat meningkatkan jaminan kualitas dari diagnostik yang dibutuhkan (Soekersi et al., 2022).

Untuk banyak kasus yang sulit, mamografi sinar-X saja mungkin tidak cukup sensitif atau akurat dalam mendeteksi kanker, sehingga teknologi pencitraan tambahan, seperti ultrasonografi atau pencitraan resonansi magnetik (MRI) juga dapat digunakan untuk meningkatkan sensitivitas pemeriksaan. Penelitian menunjukkan bahwa jenis pengobatan nuklir yang disebut pencitraan payudara molekuler (MBI) dapat menjadi alternatif yang efektif dan lebih murah daripada MRI untuk memperjelas hasil tes pada pasien dengan payudara padat. Selama MBI, pasien diberikan suntikan molekul radioaktif yang secara selektif diambil oleh sel kanker. Kamera khusus yang mendeteksi radioaktivitas kemudian digunakan untuk mengungkap sel kanker ini di jaringan payudara (NIBIB, 2024).

I. Faktor Risiko Kanker Payudara

Berikut ini merupakan faktor risiko dari penyakit kanker payudara menurut (Kemenkes RI, 2024) dan (CDC, 2024) yaitu:

1. Usia

Risiko kanker payudara meningkat seiring bertambahnya usia. Sebagian besar kanker payudara didiagnosis setelah usia 50 tahun.

2. Riwayat Reproduksi

Menstruasi yang dimulai sebelum usia 12 tahun dan menopause yang dimulai setelah usia 55 tahun membuat wanita terpapar hormon lebih lama, sehingga meningkatkan risiko terkena kanker payudara. Selain itu,

kehamilan pertama setelah usia 30 tahun, tidak menyusui, dan tidak pernah hamil cukup bulan dapat meningkatkan risiko kanker payudara.

3. Mutasi genetik

Perubahan bawaan (mutasi) pada gen tertentu, seperti BRCA1 dan BRCA2, meningkatkan risiko kanker payudara dan ovarium.

4. Riwayat keluarga

Memiliki riwayat keluarga kanker payudara dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Misalnya, risiko mungkin lebih tinggi jika ibu, saudara perempuan, atau anak perempuan (kerabat tingkat pertama) seseorang atau beberapa anggota keluarga dari pihak orang tua pernah menderita kanker payudara, atau jika seorang kerabat menderita kanker payudara di usia muda. Riwayat keluarga kanker ovarium atau kanker payudara pada kerabat laki-laki juga meningkatkan risiko.

5. Riwayat kanker payudara atau penyakit payudara lainnya

Wanita yang pernah menderita kanker payudara lebih mungkin terkena kanker payudara untuk kedua kalinya. Beberapa penyakit payudara nonkanker seperti hiperplasia duktal atipikal atau karsinoma lobular in situ dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terkena kanker payudara.

6. Terapi hormon

Beberapa bentuk terapi penggantian hormon (yang mencakup estrogen dan progesteron) yang dikonsumsi selama menopause dapat meningkatkan risiko kanker payudara jika dikonsumsi selama lebih dari 5 tahun. Kontrasepsi oral tertentu (pil KB) juga terbukti dapat meningkatkan risiko kanker payudara.

7. Memiliki payudara padat

Payudara padat terkadang membuat tumor sulit terlihat pada mammogram. Wanita dengan payudara padat juga lebih mungkin terkena kanker payudara.

8. Kelebihan berat badan atau obesitas setelah menopause
Wanita lanjut usia yang kelebihan berat badan atau obesitas memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker payudara dibandingkan mereka yang memiliki berat badan sehat.

Bab 3

Konsep Dasar Edukasi Kesehatan

A. Definisi Media Edukasi Kesehatan

Edukasi kesehatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menyampaikan pesan kesehatan dengan tujuan agar meningkatkan pengetahuan seputar kesehatan dan perilaku yang mengiringinya. Edukasi kesehatan juga merupakan hal penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan sekitarnya. Pendidikan kesehatan merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. Secara konsep edukasi kesehatan merupakan upaya mempengaruhi atau mengajak orang lain agar berperilaku hidup sehat (Widodo, 2014).

Terkait dengan hal ini, maka akan melibatkan berbagai komponen sebagai bahan masukan salah satunya adalah alat-alat bantu atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan tersebut (Milah, 2022). Media edukasi kesehatan adalah

sarana yang digunakan dalam menampilkan pesan oleh komunikator sehingga tujuan dalam meningkat pengetahuan yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah lebih baik (T.Bolon, 2021).

B. Tujuan dan Manfaat Media Edukasi Kesehatan

Tujuan dan manfaat penggunaan media untuk edukasi kesehatan antara lain dapat meningkatkan minat sasaran, dapat menjangkau sasaran yang lebih banyak, dapat membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman atau persepsi, dapat menstimulasi sasaran untuk meneruskan pesan-pesan yang diterima kepada orang lain, dapat mempermudah penyampaian bahan atau informasi kesehatan, dapat mempermudah penerimaan informasi oleh masyarakat, dapat mendorong keinginan orang untuk mengetahui, lebih mendalami, dan akhirnya mendapatkan pengertian yang lebih baik, dapat membantu menegaskan pengertian yang diperoleh, dapat memperlancar komunikasi dapat menampilkan obyek yang tidak bisa ditangkap oleh mata, serta mengurangi komunikasi secara verbal (Indrayani & Syafar, 2020).

Edukasi kesehatan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan. Menurut WHO edukasi kesehatan memiliki tujuan yang beragam terutama bagi masyarakat. Adapun tujuan tersebut antara lain:

1. Menjadikan kesehatan sesuatu yang bernilai dimasyarakat
2. Menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat

3. Mendorong dan mengembangkan secara pekat sarana pelayanan kesehatan yang ada

C. Hubungan Edukasi Kesehatan dengan Promosi Kesehatan

Kesehatan berbasis masyarakat merupakan ruang lingkup dari edukasi kesehatan yang dapat dijabarkan dari berbagai dimensi diantaranya adalah dimensi sasaran edukasi kesehatan, dimensi tempat pelaksanaan atau aplikasinya, dan dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Edukasi kesehatan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dengan promosi kesehatan yaitu suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya dan tidak hanya mengikat diri pada peningkatan pengetahuan, sikap dan praktek kesehatan saja tetapi juga meningkatkan dan memperbaiki lingkungan (Notoadmojo, 2014).

Adapun dimensi dalam melakukan sasaran edukasi kesehatan dapat dirinci sebagaimana berikut:

1. Dimensi sasaran

Dimensi sasaran dalam ruang lingkup pendidikan kesehatan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu.
- b. Pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok.
- c. Pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat luas

2. Dimensi tempat pelaksanaan

Edukasi kesehatan dapat berlangsung di berbagai tempat dengan sasaran berbeda antara lain:

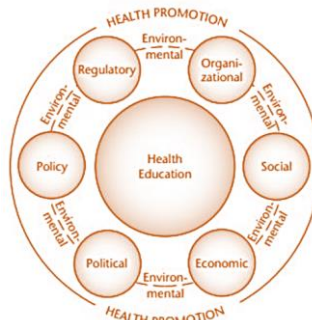
- a. Pendidikan kesehatan di sekolah dengan sasaran murid sekolah ataupun guru
 - b. Pendidikan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas dengan sasaran pasien atau keluarga pasien.
 - c. Pendidikan kesehatan di tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan.
3. Dimensi tingkat pelayanan kesehatan
- Dimensi tingkat pelayanan kesehatan terbagi menjadi lima tingkatan yaitu:
- a. Promosi kesehatan
Pada tingkat ini pendidikan kesehatan sangat diperlukan seperti: peningkatan gizi, perbaikan kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan serta higiene perorangan.
 - b. Perlindungan khusus
Program imunisasi sebagai bentuk pelayanan perlindungan khusus sangat dibutuhkan terutama di negara berkembang. Hal ini juga sebagai akibat dari kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang imunisasi sebagai perlindungan terhadap penyakit pada dirinya maupun anak-anak masih rendah
 - c. Diagnosis dini dan pengobatan segera
Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit maka sering kesulitan mendeteksi penyakit yang terjadi pada masyarakat, bahkan masyarakat sulit atau tidak mau diperiksa dan diobati sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
 - d. Pembatasan kecacatan
Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit sehingga masyarakat tidak melanjutkan pengobatan sampai tuntas. Dengan kata

lain pengobatan dan pemeriksaan yang tidak sempurna mengakibatkan orang tersebut mengalami ketidakmampuan atau kecacatan.

e. Rehabilitasi

Untuk memulihkan kecacatan kadang-kadang diperlukan latihan-latihan tertentu. Karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat segan melakukan latihan yang dianjurkan.

Promosi kesehatan merupakan kombinasi terencana dari mekanisme pendidikan, politik, lingkungan, peraturan, atau organisasi yang mendukung tindakan dan kondisi kehidupan yang kondusif bagi kesehatan individu, kelompok, dan komunitas. Sementara pendidikan kesehatan merupakan setiap kombinasi dari pengalaman belajar yang direncanakan berdasarkan teoriteori suara yang memberikan individu, kelompok, dan masyarakat kesempatan untuk memperoleh informasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan kesehatan yang berkualitas (Gate, 2014).



Gambar 3.1 Hubungan Edukasi Kesehatan dengan Promosi Kesehatan

Sumber: (Gate, 2014) dalam (Aji et al., 2023)

D. Prinsip Edukasi Kesehatan

Dalam melakukan edukasi kesehatan kita dituntut untuk memiliki prinsip yang sejalan agar proses penyampaian informasi kesehatan tersebut tepat sasaran. Adapun prinsip-prinsip edukasi kesehatan yang perlu dijaga menurut (Sinaga et al., 2021) adalah sebagai berikut:

1. Edukasi kesehatan berbeda halnya dengan pembelajaran di dalam kelas, tetapi merupakan sekumpulan pengalaman yang dapat memengaruhi pengetahuan, sikap dan kebiasaan dari target (sasaran) edukasi, contohnya: individu, kelompok ataupun masyarakat luas.
2. Edukasi kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan perilakunya sendiri
3. Sebagai seorang edukator atau pendidik memiliki kewajiban untuk menciptakan cara agar individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dapat mengubah sikap dan perilakunya sendiri.
4. Edukasi kesehatan dikatakan berhasil apabila sasaran pendidikan sudah mengubah sikap dan perilakunya sesuai dengan tujuan awal kesehatan yang telah ditetapkan.

E. Tahap Pelaksanaan Edukasi Kesehatan

Dalam melakukan edukasi kesehatan perlu ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Menurut (Fitriani, 2011) terdapat empat tahapan pelaksanaan edukasi kesehatan antara lain:

1. Tahap sensitisasi

Pada tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan kesadaran pada masyarakat tentang hal penting mengenai masalah kesehatan seperti

kesadaran pemanfaatan fasilitas kesehatan, wabah penyakit, imunisasi, dsb.

2. Tahap publisitas

Tahap ini merupakan tahapan lanjutan dari tahap sensitisasi. Bentuk kegiatan berupa *Press release* yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang terkait untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis atau macam informasi kesehatan terutama informasi tentang pelayanan kesehatan.

3. Tahap edukasi

Tahap ini kelanjutan pula dari tahap sensitisasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap serta mengarahkan pada perilaku yang diinginkan. Contoh: ibu hamil memahami bahwa pentingnya pemeriksaan secara rutin dan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan.

4. Tahap motivasi

Tahap kelanjutan dari tahap edukasi. Masyarakat setelah mengikuti benar-benar kegiatan pendidikan kesehatan benar-benar mampu mengubah perilakunya sesuai dengan yang dianjurkan kesehatan.

Contoh: setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang cara mencuci tangan masyarakat mampu untuk melakukan cuci tangan dengan alir mengalir seperti yang telah dianjurkan.

F. Strategi Edukasi Kesehatan

Pelaksanaan edukasi kesehatan memiliki tujuan yang berbeda pada setiap situasi maka dari itu diperlukan strategi yang tepat dalam melaksanakan edukasi kesehatan. Menurut (Notoadmojo, 2014) strategi yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan edukasi kesehatan antara lain:

1. Penyebarluasan Informasi Kesehatan

Kegiatan ini meliputi pengkajian sosial budaya kesehatan, sistem komunikasi dan teknologi yang tepat dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan penciptaan dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui media massa agar pesan kesehatan menjadi bagian yang terpadu dalam tatanan di masyarakat.

2. Pengembangan Potensi Swadaya Masyarakat di Bidang Kesehatan

Kegiatan ini meliputi pengembangan sikap, kemampuan dan motivasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pembiasaan hidup sehat.

3. Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan

Kegiatan ini diselenggarakan melalui pengembangan sikap, kemampuan dan motivasi petugas kesehatan baik pemerintah maupun swasta di bidang penyuluhan, institusi pendidikan dan litbang serta pembentukan kemitraan antara pemerintah, kelompok profesi dan masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan.

G. Metode Edukasi Kesehatan

Menurut (Notoadmojo, 2014) terdapat berbagai macam metode yang dapat diterapkan dalam melakukan edukasi kesehatan antara lain:

1. Metode Individual (Perorangan)

Metode yang bersifat individual digunakan untuk membina perilaku baru, atau membina seseorang yang mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan

atau perilaku baru. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan ketika menggunakan metode perorangan adalah sebagai berikut:

a. Bimbingan dan Penyuluhan (*Guidance and Counseling*)

Cara ini dilakukan dengan melakukan kontak antara klien dengan petugas secara lebih intensif. Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat diteliti dan dibantu penyelesaiannya. Akhirnya klien tersebut akan dengan sukarela dan berdasarkan kesadaran, penuh perhatian, akan menerima perilaku baru.

b. Wawancara (*Interview*)

Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk menggali informasi mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan, apakah ia tertarik atau tidak terhadap perubahan.

2. Metode Kelompok

Dalam memilih metode pendidikan kelompok, harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal pada sasaran. Jumlah anggota dalam setiap kelompok akan mempengaruhi bagaimana metode tersebut dilakukan. Metode yang dapat digunakan dalam kelompok antara lain:

a. Kelompok Besar

Pada kelompok besar terdapat cara yang dapat digunakan agar edukasi kesehatan berjalan dengan baik yaitu menggunakan 1) Ceramah: metode ini baik untuk sasaran dengan latar belakang apapun misalnya pendidikan tinggi maupun rendah; 2) Seminar: metode ini merupakan suatu penyajian (presentasi) dari satu ahli atau beberapa ahli tentang

suatu topik yang dianggap penting dan biasanya dianggap hangat di masyarakat.

b. Kelompok Kecil

Pada kelompok yang lebih kecil terdapat pendekatan yang dapat digunakan pula agar edukasi kesehatan berhasil. Adapun pendekatan tersebut menggunakan 1) Diskusi Kelompok: metode diskusi kelompok digunakan agar semua anggota kelompok dapat bebas berpartisipasi dalam diskusi maka formasi duduk para peserta diatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat berhadapan-hadapan atau saling memandang satu sama lain, misalnya dalam bentuk lingkaran atau segi empat; 2) Curah pendapat: Curah Pendapat (*Brain Storming*): metode ini merupakan modifikasi metode diskusi kelompok. Prinsipnya sama dengan metode diskusi kelompok. Bedanya, pada permulaannya pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah kemudian tiap peserta memberikan jawaban-jawaban atau tanggapan dengan cara berpendapat. Semua pendapat yang diutarakan oleh peserta tidak ada yang benar ataupun salah; 3) Memainkan Peranan (*Role Play*): Dalam metode ini, beberapa anggota kelompok ditunjuk sebagai pemegang peranan tertentu untuk memainkan peranan, misalnya sebagai dokter puskesmas, sebagai perawat atau bidan dan sebagainya, sedangkan anggota yang lain sebagai pasien atau anggota masyarakat. Mereka akan memeragakan misalnya bagaimana caranya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dsb.

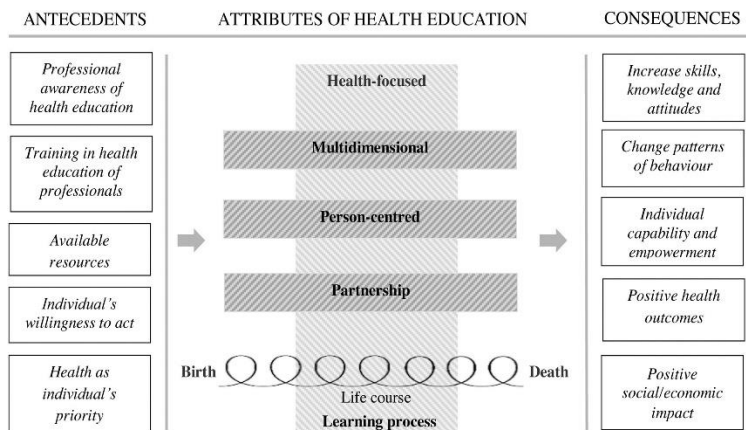
3. Metode Massa

Metode (pendekatan) massa cocok untuk mengomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat. Karena sasaran ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya. Maka pesan-pesan kesehatan yang akan disampaikan harus dirancang demikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh massa tersebut. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi kesehatan. Beberapa metode yang dapat dilakukan dengan pendekatan massa antara lain 1) Ceramah Umum: pada cara-cara tertentu misalnya pada hari kesehatan nasional seorang praktisi kesehatan atau yang lainnya dapat berpidato dihadapan massa rakyat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan; 2) Berbincang-bincang (*Talk Show*): metode ini biasa muncul melalui media elektronik, baik TV maupun radio.

H. Model Konseptual dalam Edukasi Kesehatan

Edukasi kesehatan adalah suatu proses belajar mengajar yang berkesinambungan, dinamis, kompleks dan terencana sepanjang rentang hidup dan dalam berbagai lingkungan yang dilaksanakan melalui suatu kemitraan yang adil dan dinegosiasikan antara klien dan tenaga kesehatan untuk memfasilitasi dan memberdayakan seseorang untuk merubah perilaku yang berhubungan dengan gaya hidup yang meningkatkan status kesehatan kearah yang lebih baik. Pueyo-garrigues et al pada tahun 2019 menyoroti tiga komponen penting dalam edukasi kesehatan yaitu *antecedence*, *attributes of health education* dan

consequences. *Antecedence* diartikan sebagai komponen pendahuluan sebelum melakukan edukasi kesehatan. *Consequences* diartikan sebagai hasil akhir yang diharapkan dari edukasi kesehatan. Sedangkan, *attributes of health* diartikan sebagai suatu keadaan yang mirip dengan kesejahteraan fisik, sosial, dan mental yang lengkap dan bukan hanya sekadar tidak adanya penyakit.



Gambar 3.2 Model Konseptual dalam Edukasi Kesehatan

Sumber: (Pueyo-garrigues et al., 2019)

1. *Antecedence* (komponen pendahuluan)
Terdapat lima komponen pendahuluan dalam edukasi kesehatan yaitu:
 - a. Kesadaran profesional akan pendidikan kesehatan mengacu pada fakta bahwa penyedia layanan kesehatan perlu menyadari bahwa faktor pendorong individu (internal dan eksternal), yang sering kali berada di luar kendali individu, menentukan penyebab, sifat, dan prevalensi status kesehatan negatif apa pun.
 - b. Mendidik dan melatih tenaga kesehatan berkaitan dengan kebutuhan tenaga kesehatan untuk terlatih

dengan baik, siap, berpengetahuan luas, dan percaya diri saat menangani kegiatan pendidikan kesehatan yang kompleks dengan klien (Bezerra, 2014).

- c. Dukungan dan sumber daya yang tersedia menjelaskan bahwa intervensi edukasi kesehatan agar dijalankan dengan efektif, diperlukan perencanaan, dukungan dari berbagai pihak direncanakan dan dievaluasi dengan baik.
- d. Kemauan individu untuk berubah berarti bahwa profesional perawatan kesehatan perlu memahami dengan jelas kapasitas, kemampuan, dan kemauan klien untuk mengembangkan keterampilan kesehatan pribadi sebelum menerapkan intervensi pendidikan kesehatan.
- e. Kesehatan sebagai prioritas individu dalam hidup diasumsikan bahwa individu menghargai dan memprioritaskan kesehatan mereka sebagai hal yang penting dan oleh karena itu, wajar jika profesional bertindak berdasarkan hipotesis tersebut.

2. *Attributes of Health*

Terdapat lima atribut sebagai komponen utama didalam proses edukasi kesehatan yaitu:

- a. Proses pembelajaran merupakan input dari proses edukasi kesehatan. Agar pembelajaran dapat berlangsung perlu direncanakan dan dirancang dengan baik. Hal ini akan memfasilitasi partisipasi aktif seseorang dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kesehatan dan penggabungan basis pengetahuan, sikap, keyakinan, dan keterampilan seseorang.
- b. Fokus pada kesehatan. Sejalan dengan hal ini, lintasan yang berfokus pada kesehatan didukung oleh gagasan kesehatan sebagai kontinum yang dinamis dan cair dari puncak dan palung yang berhubungan dengan

kesehatan yang berfluktuasi sepanjang proses normal rentang hidup.

- c. Multidimensi sebagai komponen utama dalam edukasi kesehatan diartikan pada kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pribadi/sosial yang sangat diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai situasi (hambatan dan pendorong) yang terkait dengan status kesehatan mereka.
- d. Pendekatan yang berpusat pada kebutuhan manusia atau masyarakat pada umumnya yang menjadi fokus anatar hubungan klien dan profesional kesehatan (Guzys et al., 2020).
- e. Kemitraan hadir sebagai proses yang aktif dan kolaboratif, yang didukung oleh prinsip-prinsip rasa hormat, otonomi, kesukarelaan, kebebasan memilih, dan kesetaraan. Kemitraan melibatkan kontak pribadi yang berkelanjutan untuk membangun tanggung jawab bersama guna mencapai dan mempertahankan tujuan kesehatan yang disepakati (Salci et al., 2013).

3. *Consequences* (hasil akhir yang diharapkan)

Hasil akhir yang diharapkan dalam edukasi kesehatan diidentifikasi sebagaimana berikut:

- a. Peningkatan literasi dan pengetahuan kesehatan, keterampilan dan/atau sikap terhadap status kesehatan yang positif
- b. Perubahan pola perilaku kesehatan yang nyata termasuk mereka yang berisiko tinggi atau memiliki penyakit, penyakit atau disabilitas yang berhubungan dengan gaya hidup

- c. Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan individu, yang mendorong kontrol yang lebih baik terhadap situasi sosial dan lingkungan sekitar dan kesadaran yang lebih besar dalam hal membuat pilihan kesehatan yang tepat
- d. Hasil kesehatan yang positif, mulai dari kepatuhan yang lebih baik terhadap pengobatan dan mengatasi penyakit, penyakit, dan disabilitas yang berkelanjutan hingga peningkatan pengambilan keputusan, kapasitas, otonomi, harga diri, kepercayaan diri, kepuasan, persepsi kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik terkait dengan tempat dan komunitas
- e. Dampak sosial ekonomi yang positif melalui pengurangan masalah kesehatan seperti rawat inap di rumah sakit, penggunaan obat yang lebih rendah, penyakit penyerta, dll.

I. Proses Edukasi Kesehatan

Menurut (Fitriani, 2011) dalam proses edukasi kesehatan terdapat beberapa persoalan pokok yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Persoalan masukan (input)

Menyangkut pada sasaran belajar (sasaran didik) yaitu individu, kelompok serta masyarakat yang sedang belajar itu sendiri dengan berbagai latar belakangnya seperti umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, kepercayaan dan keterampilan yang dimiliki setiap orang akan berbeda.

2. Persoalan proses

Mekanisme dan interaksi terjadinya perubahan kemampuan (perilaku) pada diri subjek belajar tersebut. Dalam proses ini terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai faktor antara lain subjek belajar, pengajar

(pendidik dan fasilitator), metode, tehnik belajar, alat bantu belajar serta materi atau bahan yang dipelajari.

3. Persoalan keluaran (*output*)

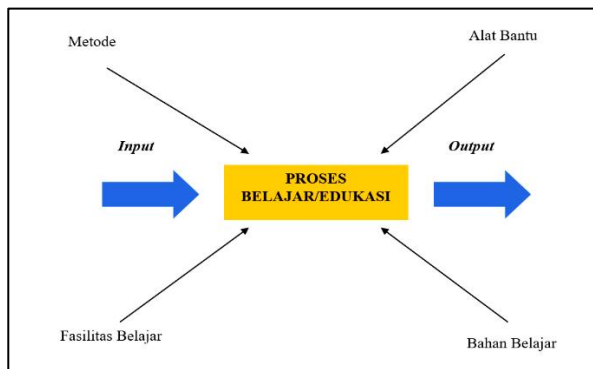
Merupakan hasil belajar itu sendiri yaitu berupa kemampuan atau perubahan perilaku dari subjek belajar yang telah mendapatkan pengajaran.

4. *Instrumental* (alat) *input*

Merupakan alat yang digunakan untuk proses belajar yang terdiri dari program pengajaran, bahan pengajaran, tenaga pengajar, sarana, fasilitas dan media pembelajaran.

5. *Environtmental* (lingkungan) *input*

Lingkungan belajar baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Proses belajar sangat dipengaruhi oleh keadaan individu pelajar secara keseluruhan.



Gambar 3.3 Proses Belajar atau Edukasi

Sumber: (MRL et al., 2019)

J. Sasaran Edukasi Kesehatan

Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia menurut (Siregar, 2020) adalah sebagaimana berikut:

1. Masyarakat umum.

Masyarakat umum adalah seluruh masyarakat yang berada disuatu tempat secara umum yang mendapatkan pendidikan kesehatan, contoh: terjadinya kasus endemis fillariasis di sebuah desa maka seluruh masyarakat di desa tersebut harus mendapatkan pendidikan kesehatan dan pengobatan terkait eliminasi fillariasis.

2. Masyarakat dalam kelompok

Masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, remaja dan anak-anak. Kelompok tertentu menjadi sasaran pendidikan kesehatan karena rentan terhadap permasalahan kesehatan.

3. Sasaran individu

Dilakukan melalui pendidikan kesehatan individual. Sasaran pendidikan kesehatan kepada individu dilakukan karena terdapat individu yang mengalami permasalahan kesehatan secara khusus sehingga memerlukan pendidikan kesehatan agar permasalahan kesehatannya tidak semakin parah atau permasalahannya tidak menular.

Bab 4

Konsep Pemanfaatan Media Leaflet dalam Edukasi Kesehatan Kanker Payudara

A. Definisi Media Edukasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) media merupakan sebuah alat atau sarana. Secara umum media merupakan alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak kata *medium*. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan (*a source*) dengan penerima pesan (*a receiver*) (Indriana, 2011). Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses edukasi diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal (Rasyad, 2011). Media sebagai suatu alat atau sejenisnya yang dapat dipakai sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pesan yang dimaksud adalah materi ataupun informasi kesehatan, dimana keberadaan media tersebut bertujuan untuk pesan yang disampaikan akan mudah dipahami dan dimengerti (Indrayani, 2020).

Sedangkan, media edukasi diartikan sebagai alat bantu untuk menyampaikan informasi seputar kesehatan, karena alat-alat tersebut digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien (Fitriani, 2011). Penggunaan media dalam edukasi kesehatan memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja pemberi informasi sehingga hasilnya akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media edukasi ini dapat berwujud manusia, benda, atau kejadian yang membantu klien untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan (Khasanah et al., 2023).

B. Manfaat Media Edukasi Kesehatan

Maulana (2009) dalam (Khasanah et al., 2023) mengatakan bahwa media dalam kegiatan edukasi kesehatan memiliki beragam manfaat antara lain:

1. Memunculkan minat pada orang yang menjadi sasaran edukasi kesehatan.
2. Efektif dalam mencapai sasaran dengan lebih baik.
3. Membantu dalam mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses penyuluhan.
4. Merangsang ketertarikan orang yang menjadi sasaran edukasi kesehatan untuk berbagi pesan dengan orang lain.
5. Mempermudah proses penyampaian informasi.
6. Memudahkan penerimaan informasi oleh orang yang mendengarkannya.
7. Pengetahuan manusia sebagian besar disalurkan melalui mata, yakni sekitar 75-87%, dibandingkan dengan indera lainnya yang hanya sekitar 13-25%. Oleh karena itu, disarankan untuk lebih banyak menggunakan media visual ketika menyampaikan informasi.

8. Mendorong minat untuk lebih mengeksplorasi dan memahami informasi dengan lebih baik.
9. Mendukung retensi pengetahuan yang telah diterima, sehingga informasi tersebut tetap terjaga dalam ingatan untuk jangka waktu yang lebih lama.

C. Prinsip Penggunaan Media dalam Edukasi Kesehatan

Pada penggunaannya, media promosi kesehatan memiliki beberapa prinsip. Menurut (Notoadmojo, 2014) prinsip tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Semakin banyak indera yang digunakan untuk menerima pesan dan informasi kesehatan dari sebuah media, maka semakin tinggi atau jelas dalam memahami pesan yang diterima.
2. Setiap jenis media yang digunakan sudah pasti memiliki kelemahan dan kelebihan.
3. Perlu digunakannya berbagai macam variasi media namun tidak perlu berlebihan dalam penggunaannya.
4. Pengguna media dapat memotivasi sasaran untuk berperan aktif dalam penyampaian informasi atau pesan.
5. Rencanakan secara matang terlebih sebelum media digunakan atau dikonsumsi oleh sasaran.
6. Hindari penggunaan media sebagai selingan atau pengisi waktu kosong saja.
7. Persiapan yang cukup dalam penggunaan media.

D. Jenis Media Edukasi Kesehatan

Berdasarkan fungsinya sebagai penyalur dan penyebarluasan informasi media edukasi kesehatan. Menurut (Fitriani, 2011), media edukasi kesehatan terbagi atas tiga jenis antara lain:

1. Media Cetak

Media cetak sering digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan-pesan dalam bidang kesehatan, beberapa media yang digunakan adalah *booklet*, *leaflet*, rubrik dan poster.

- a. *Booklet* merupakan media berbentuk buku berupa tulisan dan gambar dengan tujuan menyampaikan pesan kesehatan.
- b. *Leaflet* merupakan media yang berbentuk kertas lipat berisi informasi.
- c. Rubrik merupakan media seperti 2 majalah yang berisi bahasan masalah dalam kesehatan.
- d. Poster merupakan media cetak berisikan pesan-pesan atau informasi tentang kesehatan biasanya poster ditemukan di tempat-tempat umum.

2. Media elektronik

Media elektronik adalah suatu media bergerak dan dinamis, dapat dinikmati secara audio dan visual dalam penyampaian informasi atau pesan-pesan dalam bidang kesehatan. Contoh media elektronik diantaranya TV, radio, film, video film, CD dan VCD.

3. Media luar ruangan

Sesuai namanya, media luar ruangan merupakan media yang menyampaikan pesan-pesan di luar ruangan melalui media cetak dan elektronika secara statis, seperti papan reklame, spanduk, *banner* dan layar lebar. Menurut (Khasanah et al., 2023), media luar ruang memiliki kelebihan seperti dapat mencakup semua panca indera, mudah dipahami, menarik karena menggabungkan suara dan gambar bergerak, serta bisa bertatap muka dengan audiensnya. Namun, penggunaan media luar ruang juga memiliki beberapa kekurangan, termasuk biaya yang lebih tinggi dan persiapan yang lebih matang.

E. Kriteria Memilih Media Edukasi Kesehatan

Menurut (Jatmika et al., 2019) dalam menggunakan media dalam edukasi kesehatan, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Aksesibilitas

Pertimbangan utama adalah sejauh mana media edukasi kesehatan tersebut dapat diakses, apakah tersedia, mudah diakses, dan dapat digunakan oleh audiensnya. Misalnya, jika kita ingin menggunakan media internet, penting untuk mempertimbangkan apakah infrastruktur internet tersedia, apakah jaringan telekomunikasi berfungsi dengan baik, dan sebagainya.

2. Biaya

Aspek biaya juga harus dipertimbangkan dalam memilih media edukasi kesehatan. Biasanya media yang canggih memiliki biaya yang lebih tinggi. Namun, biaya ini harus dievaluasi dengan manfaatnya, karena semakin banyak orang yang dapat dijangkau oleh media tersebut, maka biaya per unit media tersebut akan semakin rendah.

3. Teknologi

Terlepas dari ketertarikan pada suatu jenis media, penting untuk memeriksa ketersediaan teknologi yang dibutuhkan dan kemudahan penggunaannya. Sebagai contoh, jika kita berencana menggunakan media audio visual, perlu memastikan ketersediaan pasokan listrik, voltase yang memadai, dan memahami cara pengoperasiannya.

4. Interaktivitas

Media promosi kesehatan yang efektif adalah yang memungkinkan komunikasi dua arah atau interaksi. Media yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran atau penyuluhan yang ingin dicapai.

5. Dukungan Sumber Daya

Penting untuk mempertimbangkan dukungan dari organisasi yang terlibat dalam kegiatan promosi kesehatan untuk menyediakan berbagai fasilitas seperti tempat sumber belajar.

F. Pemanfaatan Media Leaflet dalam Edukasi Kesehatan

Penggunaan leaflet sebagai media dalam edukasi kesehatan telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan tindakan responden terkait penerapan protokol kesehatan. Hasil dari edukasi kesehatan ini menunjukkan peningkatan tingkat pengetahuan responden setelah mereka diberikan informasi melalui media leaflet. Ini menunjukkan bahwa penggunaan media tersebut berhasil dalam menyampaikan informasi kesehatan yang menghasilkan perubahan perilaku yang lebih baik terkait penerapan protokol kesehatan (Rahayu, 2020).

Peningkatan pengetahuan WUS terkait upaya deteksi dini kanker payudara selain menggunakan video, digunakan juga media *leaflet* sebagai media konvensional yang memiliki banyak manfaat (Syifa et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan WUS terkait SADARI sebelum menerima edukasi kesehatan dengan leaflet rendah, namun setelah mendapatkan edukasi kesehatan dengan menggunakan media leaflet mengalami peningkatan pada pengetahuan terkait SADARI (Atnesia Ajeng & Rini Yunita, 2018) (D. E. Lestari et al., 2021).

Media leaflet dalam edukasi kesehatan memiliki efektifitas yang baik sebagai pesan visual edukasi kesehatan dalam meningkatkan perilaku kesehatan (Masthura et al., 2019). Selain itu desain leaflet mudah dirancang dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama (Jumadewi,

2024). Penelitian lain menyebutkan bahwa leaflet merupakan salah satu media edukasi yang mampu mempengaruhi pengetahuan, sikap dan tindakan kesehatan masyarakat (Leonita & Jalinus, 2018).

Pemberian edukasi kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan yang merupakan dasar terbentuknya tindakan seseorang. Edukasi kesehatan yang baik itu melibatkan media yang menunjang dalam proses pembelajaran dan promosi kesehatan. Tanpa menggunakan media, maka edukasi dengan promosi kesehatan menjadi membosankan dan berakibat pemberian informasi tidak tersalurkan dengan baik karena kurangnya fokus dalam proses edukasi. Namun, penggunaan media yang baik dan menarik dalam pemberian informasi dapat memberi dampak positif lebih besar karena menjangkau publik secara luas, memiliki dampak sosial dan budaya sehingga dapat berperan sebagai pemberi informasi, mendidik, dan menghibur masyarakat untuk membangun opini dan kesadaran publik (Aisyaroh et al., 2024) (Anisa & Dewi, 2022).

Dalam pembuatan leaflet yang baik perlu memperhatikan kaidah penggunaan bahasa yang baik dan sederhana, mudah dipahami pembaca, judul yang menarik, perpaduan tulisan dan gambar yang berkesinambungan, serta materi sesuai dengan sasaran yang dituju. Pembuatan leaflet yang baik dan menarik diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi leaflet sebagai media edukasi kesehatan SADARI sehingga menjangkau oleh banyak orang dari segala kalangan (Y. Lestari et al., 2022).

Bab 5

Penutup

Kanker payudara merupakan penyakit kanker penyumbang kematian terbesar pada perempuan di seluruh dunia. Insiden kanker payudara di Indonesia sebenarnya tidak tinggi dibandingkan negara lain. Namun walaupun di beberapa negara lain angka insidennya lebih tinggi, angka kematian mereka jauh lebih rendah dari pada Indonesia. Fakta ini terjadi karena kebanyakan perempuan penderita kanker payudara di Indonesia datang dalam kondisi lanjut lokal atau lanjut. Sedangkan angka mortalitas kanker payudara sangat bergantung pada stadium saat diagnosis kanker payudara ditegakkan. Keterlambatan deteksi kanker payudara menjadi penyebab tingginya mortalitas kanker payudara di Indonesia.

Untuk menekan angka morbiditas dan mortalitas diperlukannya edukasi kesehatan pada WUS menggunakan media yang memungkinkan penggunaanya mendapatkan banyak manfaat. Salah satu media tersebut adalah leaflet. Walaupun media edukasi leaflet terkesan konvensional namun, media ini menjadi salah satu pilihan dengan aksesibilitas yang baik terutama untuk menjangkau WUS di daerah dengan keterbatasan sumber listrik dan internet.

Kami berharap melalui buku ini dapat menjadi sebuah referensi dalam mengembangkan upaya edukasi kesehatan khususnya mengenai deteksi dini dan pencegahan kanker

payudara secara luas baik kepada individu (WUS), keluarga, kelompok masyarakat serta tenaga kesehatan khususnya. Kami memberikan rekomendasi sebagai langkah untuk terus melakukan edukasi kesehatan terkait pencegahan dan deteksi dini kanker payudara antara lain:

1. Kepada WUS agar selalu melakukan teknik SADARI sebagai langkah awal yang dapat dilakukan di rumah untuk melakukan deteksi dini adanya benjolan pada payudara.
2. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat agar terus memberikan edukasi kesehatan terutama cara deteksi dini kanker payudara melalui teknik SADARI.
3. Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dapat terus melakukan inovasi dalam memberikan rekomendasi terkait edukasi kesehatan agar informasi kesehatan terutama kanker payudara dapat diterima oleh WUS dan pasangannya di seluruh wilayah Indonesia
4. Pencegahan dan deteksi dini terkait kanker payudara perlu dilakukan secara masif, sehingga angka mortalitas dan morbiditas dapat ditekan

Kami selaku tim penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu dalam membaca dan memahami buku ini. Harapan kami agar buku ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Daftar Pustaka

- Aisyaroh, N., Fadhillah, T. S., & Rosyidah, H. (2024). Efektivitas Media Edukasi SADARI terhadap Deteksi Dini Kanker Payudara: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 7(4), 735–743. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MPPKI/article/download/4949/3796/>
- Aji, S. P., Nugroho, F. S., & Rahardjo, B. (2023). *Kesehatan Di Masyarakat (Strategi dan Tahapannya)* (N. Sulung (ed.)). Global Eksekutif Teknologi. <https://eprints.univetbantara.ac.id/id/eprint/140/1/2> BUKU Promosi Dan Pendidikan Kesehatan Di Masyarakat-1.pdf
- Anam Mumtaz, Noor Otey, Bushra Afridi, H. K. (2024). Breast cancer in pregnancy: a comprehensive review of diagnosis, management, and outcomes. *Transl Breast Cancer Res*, 5(21). <https://tbcr.amegroups.org/article/view/88698/html>
- Anisa, R., & Dewi, R. (2022). Media Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lembang. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 1919–1924. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/480/396>
- Atnesia Ajeng, Z., & Rini Yunita. (2018). Efektivitas Media Video Dan Media Leaflet Tentang Sadari (Pemeriksaan Payudara Sendiri) Terhadap Perubahan Perilaku REMAJA. *Jurnal Dinamika UMT*, 3(1), 23–30. <https://doi.org/10.31000/dinamika.v3i1.1085>
- Bezerra, S. M. M. S. (2014). Health education conception that guides the educational practice of nurses caring. *J. Nurs. UFPE*, 8(9).
- Blumen, H., Fitch, K., & Polkus, V. (2016). Comparison of Treatment Costs for Breast Cancer , by Tumor Stage and Type of Service. *American Health Drug Benefits*, 9(1), 23–32. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4822976/>

- Boere, I., & Lok, C. (2022). Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology Breast cancer during pregnancy : epidemiology , phenotypes , presentation during pregnancy and therapeutic modalities. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 82, 46–59. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2022.05.001>
- Brewer, H. R., Jones, M. E., Schoemaker, M. J., Ashworth, A., & Swerdlow, A. J. (2017). Family history and risk of breast cancer : an analysis accounting for family structure. *Breast Cancer Research and Treatment*, 165(1), 193–200. <https://doi.org/10.1007/s10549-017-4325-2>
- Cancer Research UK. (2020). *About breast cancer staging and grades*. <https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/breast-cancer/stages-grades/about>
- Candra Dewi Rahayu, S. M. (2020). Pengambilan Keputusan Klinis Perawat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 1–11. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jik/article/view/1332>
- Cardonick, Elyce MD; Gilmandyar, Dzhamala MD; Somer, R. A. M. (2012). Maternal and Neonatal Outcomes of Dose-Dense Chemotherapy for Breast Cancer in Pregnancy. *Obstetrics & Gynecology*, 120(6), 1267–1272. <https://doi.org/http://10.1097/AOG.0b013e31826c32d9>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Breast Cancer Risk Factors*. <https://www.cdc.gov/breast-cancer/risk-factors/index.html>
- Chen, X., Wang, Q., Zhang, Y., Xie, Q., & Tan, X. (2019). ScienceDirect Physical Activity and Risk of Breast Cancer : A Meta-Analysis of 38 Cohort Studies in 45 Study Reports. *Value in Health*, 22(1), 104–128. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2018.06.020>
- Dameria, D., Hulu, V. T., Siregar, S. D., Manalu, P., Samosir, F. J., Rambe, F. U. C., & Hasibuan, N. (2023). Improvement of Patients' Knowledge, Attitude, and Practice on Tuberculosis Treatment Using Video and Leaflet. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*,

18(2), 79–88. <https://doi.org/10.14710/jpki.18.2.79-88>

ESMO. (2018). *Kanker Payudara: Panduan Untuk Pasien*. Of, Indonesian Society Medical-Oncology, Hematology. <https://www.esmo.org/content/download/499311/9549936/1/1D-Kanker-Payudara-Panduan-untuk-Pasien.pdf>

Fauziah, E. N., Permata, P., & Yogyakarta, I. (2022). Literature Review Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Siklus Menstruasi Remaja Putri Analysis of Factors Affecting the Menstrual Cycle for Girls Elly Naila Fauziah peningkatkan Masa-masa Menurut WHO (2014) di dunia. *JURNAL PERMATA INDONESIA*, 13(November), 116–125. <https://jurnal.permataindonesia.ac.id/index.php/JPI/article/download/170/143>

Fitriani, S. (2011). *Promosi Kesehatan* (1st ed.). Graha Ilmu.

Foundation, N. B. C. (2024). *Types of Breast Cancer*. <https://www.nationalbreastcancer.org/types-of-breast-cancer/>

Francies, F. Z., Hull, R., Khanyile, R., & Dlamini, Z. (2020). Breast cancer in low-middle income countries : abnormality in splicing and lack of targeted treatment options. *American Journal of Cancer Research*, 10(5), 1568–1591.

Gate, E. (2014). *Principles and Foundations of Health Promotion and Education Cottrell Girvan Mckenzie* (Fifth). Pearson Education Limited.

Giovanni Corso, Mattia Intra, Chiara Trentin, P. V. & V. G. (2016). CDH1 germline mutations and hereditary lobular breast cancer. *Familial Cancer*, 15, 215–219. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10689-016-9869-5#citeas>

Guzys D, Brown R, Halcomb E, Whitehead D. (2020). *An introduction to community and primary health care*. Cambridge University Press.

Husby, A. (2018). Pregnancy duration and breast cancer risk. *Nature*

Communications, 9(4225). <https://doi.org/10.1038/s41467-018-06748-3>

Icon Cancer Center. (2024). *Panduan Perawatan Kanker Payudara*. Icon Cancer Center. https://iconcancercentre.sg/wp-content/uploads/2024/05/ASEAN-ICC-113219_Bahasa-Breast-Cancer-Guide-Download_Healthy-Lifestyle.pdf

Indriana, D. (2011). *Ragam Alat Bantu Pengajaran* (1st ed.). Diva Press. <https://onsearch.id/Record/IOS2757.slims-12140>

Iryanti, S. N. N. F. &. (2021). Influence of Education Through Leaflet Towards Housewife ' s Knowledge about. *Jurnal Riset Kesehatan*, 2(1), 31–37. <https://jks.juriskes.com/index.php/jks/article/view/1823/397>

Jack Cordes. (2021). Erratum regarding missing Declaration of Competing Interest statements in previously published articles (Spatial and Spatio-temporal Epidemiology (2020) 33, (S1877584520300010), (10.1016/j.sste.2020.100323)). *Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology*, 36, 2020–2021. <https://doi.org/10.1016/j.sste.2020.100399>

Jackson, A. S. · H. D. N. · J. G. (2020). TP53 Mutations and Outcomes in Breast Cancer: Reading beyond the Headlines. *Trends in Cancer*, 6(2), 98–110. [https://www.cell.com/trends/cancer/abstract/S2405-8033\(20\)30020-0?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405803320300200%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/trends/cancer/abstract/S2405-8033(20)30020-0?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2405803320300200%3Fshowall%3Dtrue)

Jatmika, S. E. D., Maulana, M., Kuntoro, & Martini, S. (2019). *BUKU AJAR PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN* (Eriyani Khuzaimah (ed.)). K-Media. https://eprints.uad.ac.id/15793/1/Buku_Ajar_Pengembangan_Media_Promosi_Kesehatan.pdf

Jumadewi, A. (2024). Praktik Pembelajaran Promosi Kesehatan Melalui Penyuluhan Media Leaflet. *Learning : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 872–

878.<https://jurnalp4i.com/index.php/learning/article/view/3370/2880>

Kartika Sari, Nadia Surahmi, S. (2023). Penatalaksanaan Pemeriksaan Mammografi Pada Kasus Tumor Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Ibu Dan Anak Porvinsi Aceh 2020. *Jurnal Perisai*, 02(01), 146–155.

https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/perisai/article/download/141/134?_cf_chl_tk=Xc.TRYBa4AEdX_7ZavWLMFrc0S1h2YvSOPbcW192tA8-1734770408-1.0.1.1-kqAHWdAoAiQMG33VoMa0iQv1oNHM0FejE_Uz9SPq1ec

Kemendes. (2019). *Gejala Kanker Payudara*. Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-kanker-dan-kelainan-darah/gejala-kanker-payudara>

Kemendes. (2022). *Kanker Payudara*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-penyakit/neoplasma/kanker-payudara>

Kemendes. (2024). *Rencana Kanker Nasional 2024-2034* (Issue September). <https://p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/rencana-kanker-nasional-2024-2034>

Kemendes RI. (2016). *Enam Langkah SADARI untuk Deteksi Dini Kanker Payudara*. Kementerian Kesehatan RI. <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/enam-langkah-sadari-untuk-deteksi-dini-kanker-payudara>

Kemendes RI. (2024). *Apa Penyebab Kanker Payudara?* <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-kanker-dan-kelainan-darah/page/7/apa-penyebab-kanker-payudara#:~:text=Yang diketahui adalah faktor-faktor,umur kurang dari 12 tahun>

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Payudara, 1 (2018). https://yankes.kemkes.go.id/unduhuan/fileunduhuan_1610414392_632733.pdf

- Khasanah, N., M, W. R., Setiawan, D. I., F., L. B., & Retnaningsih, L. N. (2023). *Buku Ajar Pendidikan & Promosi Kesehatan dalam Keperawatan* (Issue April). Dewa Publishing.
- Leonita, E., & Jalinus, N. (2018). Peran Media Sosial dalam Upaya Promosi Kesehatan : Tinjauan Literatur. *Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 18(2), 25–34. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=716439&val=10535&title=Peran Media Sosial Dalam Upaya Promosi Kesehatan Tinjauan Literatur](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=716439&val=10535&title=Peran%20Media%20Sosial%20Dalam%20Upaya%20Promosi%20Kesehatan%20Tinjauan%20Literatur)
- Lestari, D. E., Haryanti, T., & Igiyany, P. D. (2021). Efektivitas Media Leaflet untuk Meningkatkan Pengetahuan Siswi Tentang Sadari. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 148–154. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jppkmi/article/view/52431/20717>
- Lestari, Y., Attamimi, R., & Sari, A. (2022). The Effectiveness of Leaflets and Video Media in Increasing Knowledge About Breast Self-Examination (SADARI). *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 8(5), 2460–2464. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v8i5.1947>
- Liambo, I. S., Frisitionady, A., & Malaka, M. H. (2022). Payudara Review: Pathophysiology, Epidemiology, and Cell Line of Breast Cancer. *Jurnal Farmasi, Sains, Dan Kesehatan*, 8(1), 17–22. <https://doi.org/10.33772/pharmauho.v8i1>
- Łukasiewicz, S., Czezelewski, M., Forma, A., & Baj, Jacek, Robert Sitarz, and A. S. (2021). Breast Cancer—Epidemiology, Risk Factors, Classification, Prognostic Markers, and Current Treatment Strategies— An Updated Review. *Cancers*, 13(17), 1–30. <https://www.mdpi.com/2072-6694/13/17/4287>
- Masthura, R., Yuniwati, C., & Ramli, N. (2019). Efektivitas lembar balik dan leaflet terhadap pengetahuan ibu hamil tentang pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI). *Jurnal SAGO Gizi Dan Kesehatan*, 7(1), 9–16. <https://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/gikes/article/view/283/119>

- Mcguire, A., Brown, J. A. L., Malone, C., & Mclaughlin, R. (2015). Effects of Age on the Detection and Management of Breast Cancer. *Cancers*, 7(2), 908–929. <https://doi.org/10.3390/cancers7020815>
- Milah, A. S. (2022). *Pendidikan Kesehatan Dan Promosi Kesehatan Dalam Keperawatan*. Edu Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QBKHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA111&ots=s9O4jutTQ4&sig=K9gmfcLZpKgdvIrl6wvb8bD0R3Ho&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- MRL, A., Jaya, I. M. M., & Mahendra, D. (2019). *BUKU AJAR PROMOSI KESEHATAN*. Universitas Kristen Indonesia. <http://repository.uki.ac.id/2759/1/BUKUMODULPROMOSIKESEHATAN.pdf>
- Mustaqimah. (2023). Review : Media Leaflet Untuk Promosi Kesehatan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Karya Cendekia*, 48–51. <https://wpcpublisher.com/jurnal/index.php/prosidingkaryacendekia/article/view/368/279>
- National Breast Cancer Foundation. (2024). *Breast Cancer During Pregnancy*. <https://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-and-pregnancy/>
- NIBIB. (2024). *Mammography*. National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering. <https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/mammography>
- Nofia, P., & Indrayani, T. (2022). Efektivitas penggunaan Daun Sirsak terhadap Keputihan pada Wanita Usia Subur di Desa Belambangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022. *Journal for Quality in Women's Health*, 5(1), 114–119. <https://jqwh.org/index.php/JQWH/article/view/144>
- Notoadmojdo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Peng, Yan, C. S. K. Y.-Y. C. (2013). Practical Breast Pathology A Diagnostic Approach. In *Practical Breast Pathology A Diagnostic Approach* (pp. 147–212). Elsevier Inc. [Daftar Pustaka](https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/3-s2.0-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- Pratiwi, G. D., Vita Lucya, & Paramitha. (2022). Efektifitas Penggunaan Media Leaflet Dalam Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Pencegahan Tuberkulosis. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 8(3), 8–13. <https://doi.org/10.33023/jikep.v8i3.1153>
- Pueyo-garrigues, M., Whitehead, D., Pardavila-belio, M. I., Canga-armayor, A., Pueyo-garrigues, S., & Canga-armayor, N. (2019). International Journal of Nursing Studies Health education : A Rogerian concept analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 94, 131–138. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.03.005>
- Raihanny, Y. (2024). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Kanker Payudara terhadap Pengetahuan , Perilaku , dan Keterampilan Sadari pada Wanita Usia Subur yang Berkunjung ke PMB Utami Dewi di Cihideung Bogor Tahun 2023. *Advances in Cancer Scienc*, 1(1), 1–12. <https://acsc.pubmedia.id/index.php/acsc/article/download/1/1>
- Rasyad, A. (2011). *Media Pembelajaran*. Raja Grafindo Persada.
- Rochmawa, L., Prabawa, S., & Djalaluddin, N. M. (2021). *Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)*. ZAHIR PUBLISHING. <http://repository.stikes-yogyakarta.ac.id/id/eprint/196/1/2>. 2021-1. Monograf_Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI).pdf
- Salci, M. A., Maceno, P., Rozza, S. G., Maria, D., & Vieira, G. (2013). Health Education And Its Theoretical Perspectives : A Few Educação Em Saúde E Suas Perspectivas Teóricas : Algumas La Educación Para La Salud Y Sus Perspectivas Teóricas : *SciELO Brazil*, 22(1), 224–230. <https://www.scielo.br/j/tce/a/VSDJRgcjGyxnhKy8KvZb4vG/?lang=en>
- Sarah, D., & Frédéric, A. (2009). Breast cancer in pregnancy : a literature review. *Facts Views Vis Obgyn*, 1(2), 130–141. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4251272/pdf/FVViNO>

- Setyowibowo, H., Purba, F. D., Hunfeld, J. A. M., Iskandarsyah, A., Sadarjoen, S. S., Passchier, J., & Sijbrandij, M. (2018). Quality of life and health status of Indonesian women with breast cancer symptoms before the definitive diagnosis: A comparison with Indonesian women in general. *PLoS ONE*, 13(7), 1–11. <https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0200966&type=printable>
- Shankar, M., Swetha, M., Keerthana, C. K., & Rayginia, T. P. (2022). Cancer Chemoprevention: A Strategic Approach Using Phytochemicals. *Frontiers in Pharmacology*, 12(January), 1–25. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.809308>
- Shidqi et.al. (2022). Faktor-Faktor Keterlambatan Diagnosis Kanker pada Pasien Kanker Payudara: Systematic Review. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 7(2), 471–481.
- Shiovitz, S., & Korde, L. A. (2015). Genetics of breast cancer: a topic in evolution. *Annals of Oncology*, 26(7), 1291–1299. <https://doi.org/10.1093/annonc/mdv022>
- Shiyanbola, O. O. (2018). Emerging Trends in Family History of Breast Cancer and Associated Risk. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prevention*, 26(12), 1–19. <https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-17-0531>. Emerging
- Sihite, E. D. O., Nurchayati, S., & Hasneli, Y. (2019). Gambaran Tingkat Pengetahuan Tentang Kanker Payudara Dan Perilaku Periksa Payudara Sendiri (Sadari). *Jurnal Ners Indonesia*, 9(2), 8. <https://doi.org/10.31258/jni.10.1.8-20>
- Sinaga, L. R. V., Sianturi, E., Maisyarah, M., Amir, N., Simamora, J. P., Ashriady, A., & Hardiyati, H. (2021). *Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Yayasan Kita Menulis.
- Siregar, P. A. (2020). *Buku Ajar Promosi Kesehatan*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. http://repository.uinsu.ac.id/8775/1/Diktat_Dasar_Promkes.pdf

- Smorti, M., Ponti, L., & Tani, F. (2019). The effect of maternal depression and anxiety on labour and the well-being of the newborn. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 39(4), 492–497. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01443615.2018.1536697>
- SOBRI, F. B. (2022). *Pengembangan Model Edukasi Digital Aplikasi Mammasip Diagnosis Kanker Payudara Di Indonesia Farida Briani Sobri Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Universitas Indonesia.
- Soekersi, H., Azhar, Y., & Akbari, K. S. (2022). Peran Mammografi Untuk Skrining Kanker Payudara : Sebuah Tinjauan Pustaka. *Journal Of The Indonesian Medical Association*, 72(3), 144–150. <https://mki-ojs.idionline.org/jurnal/article/download/627/253>
- Syifa, R. M., Warastuti, D., Sabaruddin, E. E., & Hermawan, A. (2023). Efektivitas Promosi Kesehatan Media Video Dan Leaflet Pada Peningkatan Pengetahuan Remaja Putri Mengenai Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari) Pada Siswi Kelas Xi Smk Nurul Hikmah Al-Hakim Tahun 2022 The Effectiveness Of Health Promotion Video And Leaflet. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Kebidanan*, 12(1), 59–70. <https://repo.mrhj.ac.id/974/1/5-artikel-aan-dkk%281%29.pdf>
- T.Bolon, C. M. (2021). *Pendidikan Dan Promosi Kesehatan*. UIM Press. <https://storage-imelda.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/repositori/t6NJyZcb6r8v1Q1V7J6VNeudOGSiqWs36sUrLHS4.pdf>
- Triana Indrayani, M. S. (2020). *Promosi Kesehatan Untuk BIDAN*. CV. AA. RIZKY. [http://repository.unas.ac.id/610/1/Triana](http://repository.unas.ac.id/610/1/Triana%20FULL.pdf) Buku FULL.pdf
- Vandenbroucke, T., Verheecke, M., Gerwen, M. Van, Calsteren, K. Van, Halaska, M. J., Fumagalli, M., Fruscio, R., Gandhi, A., Veening, M., Lagae, L., Ottevanger, P. B., Voigt, J., Haan, J. De, Gziri, M. M., Maggen, C., Mertens, L., Naulaers, G., & Claes, L. (2020). Child development at 6 years after maternal cancer diagnosis and treatment during pregnancy. *European Journal of Cancer*, 138,

57–67. <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2020.07.004>

Voigt, J., Naulaers, G., Vallaey, L., Heuvel, F. Van Den, & Lagae, L. (2015). Pediatric Outcome after Maternal Cancer Diagnosed during Pregnancy. *The New Engl and Journal of Medicine Original*, 373(19), 1824–1834. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1508913>

WHO. (2024a). *Breast Cancer*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer>

WHO. (2024b). *SDG Indicator 3.7.1: Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) who have their need for family planning satisfied with modern methods*. <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-01.pdf>

Widodo, B. (2014). Pendidikan Kesehatan Dan Aplikasinya di SD/MI. *Madrasah*, 7(1), 89–100. <https://media.neliti.com/media/publications/146099-ID-pendidikan-kesehatan-dan-aplikasinya-di.pdf>

Wolters, V., Heimovaara, J., Maggen, C., Cardonick, E., Boere, I., Lenaerts, L., & Amant, F. (2021). Management of pregnancy in women with cancer. *International Journal Gynecological Cancer*, 31(3), 314–322. <https://doi.org/10.1136/ijgc-2020-001776>

Glosarium

A

Abnormalitas adalah ketidaksesuaian dengan keadaan yang biasa; mempunyai kelainan; tidak normal

Autosomal adalah gen pembawa terletak pada salah satu kromosom bernomor, atau non-jenis kelamin.

B

Bioaktif sintetis adalah senyawa yang terkandung dalam tumbuhan, hewan, manusia, juga bahan makanan tertentu yang memiliki fungsi fisiologis

D

Diferensiasi adalah proses, cara, perbuatan membedakan; pembedaan; perkembangan tunggal, kebanyakan dari sederhana ke rumit, dari homogen ke heterogen; proses pembedaan hak dan kewajiban warga masyarakat berdasarkan perbedaan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan

E

Elektronis adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut

Entitas adalah sesuatu yang berwujud atau maujud

F

Fluktuasi adalah perubahan nilai yang tidak menentu yang terjadi pada pasar atau merupakan kondisi tinggi rendahnya suatu harga

Fotografis adalah segala yang berkenaan dengan aktivitas mengambil gambar melalui kamera untuk menghasilkan karya seni dan bisa dinikmati baik diri sendiri atau publik

G

Grafis adalah bentuk komunikasi visual yang dirancang dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif.

H

Harfiah adalah terjemahan atau arti menurut huruf, kata demi kata.

Hormon prolaktin adalah merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari (hipofisis), sistem saraf pusat, rahim, kelenjar susu, dan sel-sel imun atau sebagai hormon yang merangsang produksi Air Susu Ibu (ASI)

I

Intravena adalah menuju kearah pembuluh darah atau metode pemberian obat melalui pembuluh darah

Infiltrat adalah gambaran benang radioopak tipis yang dapat diamati pada bagian manapun pada lapang paru namun paling sering ditemukan di dekat apeks paru

K

Karsinogenik adalah suatu zatb yang dapat memicu timbulnya berbagai jenis kanker pada tubuh

Kemoprevensi adalah penggunaan obat, vitamin, atau suplemen untuk menghentikan kanker

Kemopreventif adalah senyawa, baik alami maupun sintetis, yang mencegah, membalikkan, atau memblokir perkembangan kanker invasif

Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme

L

Leaflet adalah sarana komunikasi yang dicetak di atas kertas, dilipat dalam 2-3 bagian.

Limfoplasmasitik adalah jenis limfoma tingkat rendah yang dapat tumbuh perlahan selama bertahun-tahun.

Lumpektomi adalah prosedur bedah saat tumor atau bagian jaringan payudara yang terkena kanker diangkat

M

Mastektomi radikal adalah pengangkatan seluruh jaringan payudara, kelenjar getah bening di ketiak, kulit, hingga kedua otot dada pectoralis yang berada di bawah payudara.

Mastektomi parsial adalah mengangkat benjolan atau tumor kanker payudara beserta jaringan di sekitarnya. Namun, pada mastektomi parsial, jaringan payudara yang akan diangkat jumlahnya lebih banyak.

Menarche adalah menstruasi yang pertama kali dialami oleh perempuan

Mekanistik adalah prosedur yang ditentukan secara mekanis (sesuai dengan aturan baku).

Metastasis adalah saat kanker telah menyebar ke luar organ atau jaringan dari tempat kanker pertama kali muncul.

Mikroskopis adalah obyek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang dan perlu diperbesar menggunakan suatu alat tertentu agar dapat terlihat.

Morbiditas adalah kondisi yang ditandai dengan penyakit atau kondisi medis, baik mental maupun fisik

Mortalitas adalah jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami.

N

Nukleus adalah organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel.

O

Obesitas adalah kondisi berat badan melebihi batas normal karena adanya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh.

P

Pascamenopause adalah berakhirnya ovulasi sehingga darah menstruasi tidak keluar selama 12 bulan atau lebih.

R

Radiasi X-Ray adalah bentuk paparan yang bersifat elektromagnetik, mirip dengan cahaya tampak

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

S

SADARI adalah pemeriksaan payudara sendiri yang merupakan cara termudah untuk mendeteksi kelainan pada ukuran, tekstur, serta bentuk payudara.

Sensitisasi adalah proses di mana ambang batas potensial aksi digeser ke arah rangsangan yang kurang intens atau tindakan atau proses membuat kulit menjadi sensitif atau hipersensitif.

Sporadis adalah ketidakteraturan dalam semua aspek kehidupan atau kejadian (fenomena) yang jarang terjadi dan tidak teratur.

Sitotoksik adalah suatu senyawa atau zat yang dapat merusak sel normal atau sel kanker, serta digunakan untuk menghambat pertumbuhan dari sel.

V

Visualisasi adalah suatu rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram atau animasi untuk penampilan suatu informasi.

Profil Penulis



Legina Anggraeni, SST, MKM lahir di Jakarta pada tanggal 20 September 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kebidanan Fakultas Keperawatan Kebidanan, Universitas Binawan dan mengampu mata kuliah antara lain Asuhan Kebidanan Komplementer, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Komunitas, Psikologi Ibu dan Anak, Pengantar Praktik Kebidanan, dsb. Menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan

Program Studi Kebidanan pada tahun 2014 dan satu tahun kemudian pada tahun 2015 menyelesaikan pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di Universitas Respati Indonesia. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat dengan Peminatan Kesehatan Reproduksi di Universitas Indonesia dan pada tahun 2022 hingga saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan program doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melalui Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penulis sangat tertarik dengan *Natural Childbirth*, *Gentle Birth*, *Hypnobirthing* dan *Islamic Childbirth*. Selain berprofesi sebagai dosen penulis juga aktif melakukan penelitian dan publikasi jurnal ilmiah yang berfokus pada tema kesehatan ibu anak, kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi. Pada kesempatan lain penulis juga aktif untuk menjadi narasumber pada acara Seminar Nasional bertajuk kesehatan dan kebidanan komplementer.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

leginasyamsiar@gmail.com/legina@binawan.ac.id atau dapat melalui media sosial Instagram @ghina_syamsiar

Profil Penulis



Frida Putri Maharani, A.Md.Keb lahir di Jakarta pada tanggal 15 maret 2002 merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Penulis merupakan seorang alumni Universitas Binawan yang menempuh pendidikan di program studi Kebidanan dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2023. Saat ini penulis bekerja sebagai inspektor visual di salah satu perusahaan industri farmasi.

SINOPSIS BUKU

Buku dengan judul ***Pemanfaatan Leaflet Sebagai Media Edukasi Kesehatan: Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Wanita Usia Subur*** merupakan sebuah luaran terhadap penelitian yang telah dilakukan yaitu terkait manfaat leaflet sebagai media edukatif dalam meningkatkan pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini kanker payudara.

Penyakit kanker payudara merupakan penyakit penyebab kematian pertama pada perempuan di Indonesia dengan angka kesakitan yang juga tinggi. Pasalnya, banyak perempuan yang terlambat untuk mendapatkan pengobatan yang intensif dikarenakan terlambat dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini.

SADARI yang merupakan pemeriksaan payudara sendiri merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam mendeteksi dini benjolan yang muncul disekitar area payudara. Namun sayangnya, pengetahuan perempuan terkait hal ini masih cukup rendah.

Edukasi kesehatan terkait SADARI perlu digalakkan dengan menggunakan media edukasi yang informatif dan mudah sehingga pengetahuan tentang SADARI akan meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan WUS akan diimbangi pula dengan kesadaran pemeriksaan diri sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan penyakit kanker payudara

Buku ini dikemas dengan sedemikian rupa agar para pembaca akan memahami dengan jelas terkait penyakit kanker payudara termasuk faktor risiko dan upaya pencegahannya. Didalamnya juga terdapat pembahasan media edukasi yang relatif mudah dikembangkan untuk melakukan edukasi dan promosi kesehatan

Buku dengan judul Pemanfaatan Leaflet Sebagai Media Edukasi Kesehatan: Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Wanita Usia Subur merupakan sebuah luaran terhadap penelitian yang telah dilakukan yaitu terkait manfaat leaflet sebagai media edukatif dalam meningkatkan pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini kanker payudara.

Penyakit kanker payudara merupakan penyakit penyebab kematian pertama pada perempuan di Indonesia dengan angka kesakitan yang juga tinggi. Pasalnya, banyak perempuan yang terlambat untuk mendapatkan pengobatan yang intensif dikarenakan terlambat dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini.

SADARI yang merupakan pemeriksaan payudara sendiri merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam mendeteksi dini benjolan yang muncul disekitar area payudara. Namun sayangnya, pengetahuan perempuan terkait hal ini masih cukup rendah.

Edukasi kesehatan terkait SADARI perlu digalakan dengan menggunakan media edukasi yang informatif dan mudah sehingga pengetahuan tentang SADARI akan meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan WUS akan diimbangi pula dengan kesadaran pemeriksaan diri sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan penyakit kanker payudara.

Buku ini dikemas dengan sedemikian rupa agar para pembaca akan memahami dengan jelas terkait penyakit kanker payudara termasuk faktor risiko dan upaya pencegahannya. Didalamnya juga terdapat pembahasan media edukasi yang relatif mudah dikembangkan untuk melakukan edukasi dan promosi kesehatan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-71379-06-1



9

786347

139061